COMPENDIO DE DEFINICIONES DE CASO DE ENFERMEDADES Y OTROS EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



Enfermedad	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	Total
Enfermedad A	15	22	18	25	30	28	138
Enfermedad B	8	12	15	10	14	16	75
Enfermedad C	5	7	9	11	13	12	57
Total general	28	41	42	46	57	56	270

Lima - Perú
2026

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

PERÚ Ministerio de Salud

Tabla de contenido

Presentación....4
Vigilancia epidemiológica de EDA/IRA/SGB.... 5
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)....5
Cólera....6
Diarrea por rotavirus....7
Diarrea por Campylobacter....8
Infección Respiratoria Aguda (IRA)....9
Neumoníabacteriana....11
COVID-19....12
Virus respiratorios (influenza, virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios).... 14
Meningitis meningocócica....16
Síndrome de Guillain Barré (SGB)....17
Vigilancia epidemiológica de VIH/ITS/TB/IAAS....18
Gonorrea....18
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)....19
Sífilis....20
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)....22
Tuberculosis (TB)....23
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)....25
Vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunas....27
Difteria....27
Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) severo....28
Fiebre amarilla....29
Hepatitis b....31
Parálisis Flácida Aguda (PFA)....32
Parotiditis....34
Sarampión - Rubéola (SR)....35
Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)....37
Tétanos....38
Tétanos neonatal....39
Tos ferina....40
Varicela....42
Mpox(viruelasímica)....43
Vigilancia epidemiológica de enfermedades metaxénicas.... 45
Chikungunya....45
Dengue....47
Enfermedad de Carrión....52
Enfermedad de Chagas....55
Leishmaniasis....57
Malaria....59
Mayaro....62
Oropouche....64
Zika....66
Vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas....71
Carbunco(ántrax)....71
Fasciolosishumana....73
Leptospirosis....74

Loxoscelismo....75
Ofidismo....76
Peste....77
Rabia....79
Vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles....81
Cáncer....81
Diabetes....82
Enfermedad renal crónica terminal (ERCT)....83
Lesiones por accidentes de tránsito....84
Problemas priorizados de salud mental....85
Violencia familiar....87
Vigilancia epidemiológica materno perinatal....88
Morbilidad Materna Extrema (MME)....88
Muerte Fetal y Neonatal (MFN)....89
Muerte Materna (MM)....90
Vigilancia epidemiológica de riesgos ambientales....91
Riesgo por exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides....91
Riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas....92
Bibliografía....93

PRESENTACIÓN

El compendio de definiciones de caso de enfermedades y otros eventos sujetos a vigilancia ha sido elaborado por la Dirección de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, como instrumento técnico que reúne los criterios vigentes para las definiciones de caso de enfermedades y daños sujetos a notificación, en el marco del funcionamiento Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Este documento contiene las definiciones de caso basadas en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, alineadas con la normativa vigente del Ministerio de Salud y basadas en estándares técnicos nacionales e internacionales. La homogeneidad en la aplicación de estas definiciones constituye un pilar esencial que contribuye a garantizar la calidad, comparabilidad y oportunidad de la información, fortaleciendo los procesos de análisis e interpretación de datos para la toma de decisiones.

El compendio busca servir como herramienta de consulta permanente para el personal de salud y los equipos técnicos de la Red Nacional de Epidemiología (RENACE). Su aplicación sistemática permitirá optimizar los procesos de vigilancia, mejorar la calidad del dato y consolidar un sistema de información robusto y confiable para la protección de la salud pública.

Asimismo, señalamos nuestro compromiso, de actualizar el presente compendio, incorporando las definiciones nuevas o actualizadas conforme se emitan los documentos normativos relacionados a la vigilancia en salud pública en el país.

Vigilancia epidemiológica de EDA/IRA/SGB

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

- **EDA acuosa:** Cuadro en el que el paciente presenta aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de catorce (14) días.

- **EDA disentérica:** Cuadro en el que el paciente presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco.

- **Caso de enfermedad diarreica persistente:** Todo paciente que presenta un cuadro diarreico que se inicia como una diarrea aguda infecciosa, pero que se prolonga por catorce (14) días o más.

- **Hospitalizado por EDA:** Paciente internado con diagnóstico de EDA, con permanencia igual o mayor a 24 horas.

  En la clasificación se debe especificar si se trata de una EDA Acuosa o Disentérica según la definición.

- **Defunciones por EDA:** Fallecimiento de una persona a causa de la diarrea o cualquier gastroenteritis de origen presumiblemente infeccioso o no y, que puede o no contar con identificación del agente etiológico.

En la clasificación se debe especificar si se trata de una EDA Acuosa o Disentérica según la definición.

Fuente: *NTS N°190-MINSA/CDC-2022 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/COLERA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/eda/Ficha_EDA.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Ficha_Def-EDA.pdf

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/eda/Ficha_Colera_EDA.pdf

Cólera

- **Caso sospechoso de cólera:** Persona de cualquier edad que presenta un cuadro de diarrea acuosa de aparición brusca que lleva rápidamente a la deshidratación (Esta definición tiene mayor utilidad durante un brote o epidemia con el fin de captar precozmente los casos).

- **Caso probable de cólera**

  A. Persona de cualquier edad que presenta bruscamente un cuadro clínico de diarrea acuosa con o sin vómitos, con deshidratación severa o shock, y sin presencia de fiebre.

  B. Persona de cualquier edad que muere por un cuadro de EDA acuosa.
  (Esta definición tiene mayor utilidad en ausencia de actividad epidémica o cuando la incidencia es baja, cada caso debe ser investigado).

- **Caso confirmado de cólera**

  - Caso sospechoso o probable con aislamiento por coprocultivo de *Vibrio cholerae* O1 u O139 u otro método de diagnóstico (PCR, entre otros).

  - Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado casos de cólera en las últimas 2 semanas.

  - Todo caso probable durante un brote o epidemia donde se ha confirmado el *Vibrio cholerae* O1 u O139 en los nuevos casos.

  - Todo caso probable que es contacto familiar de un caso confirmado.

- **Caso compatible de cólera:** Cualquier caso clasificado como sospechoso o probable que no puede ser confirmado o descartado en un lapso de treinta (30) días posteriores a la clasificación inicial, en ausencia de actividad epidémica.

- **Caso de portador asintomático de Vibrio cholerae:** Toda persona en quien se ha aislado *Vibrio cholerae* toxigénico O1 y O139, sin evidencia de cuadro clínico.

- **Caso descartado de cólera:** Todo caso sospechoso o probable en el que por coprocultivo de Vibrio cholerae no se aísla el agente etiológico o no se confirma por otro método, y sin nexo epidemiológico.

Fuente: *NTS N°190-MINSA/CDC-2022 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/COLERA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha_Colera-EDA.pdf

Diarrea por rotavirus

- **Caso sospechoso:** Todo niño menor de cinco años con episodio de diarrea aguda con o sin vómitos, que requiere un tratamiento de reposición hídrica equivalente al Plan B (terapia de rehidratación oral) o Plan C (terapia de rehidratación intravenosa) en el que el profesional de la salud sospeche que la etiología corresponde a rotavirus.

Criterios de exclusión

a. Tener 5 años de edad cumplidos o más.

b. Presentar diarrea prolongada (más de 14 días de duración).

c. Hospitalizado por otra sospecha diagnóstica y que la diarrea es parte de sus síntomas o se agrega durante su estancia.

d. Haber obtenido la muestra de material fecal después de 48 horas de su hospitalización.

e. Referido por un establecimiento de salud donde estuvo hospitalizado por más de 24 horas por el cuadro de diarrea en curso.

f. Reingreso por diarrea en menos de 72 horas posterior al alta hospitalaria.

- **Caso confirmado:** Todo caso sospechoso que tiene una muestra de heces adecuada y oportuna, cuyo resultado de laboratorio es positivo a rotavirus.

- **Caso descartado:** Caso sospechoso que tiene una muestra de heces adecuada y oportuna cuyo resultado es negativo a rotavirus.

Fuente: *DS N°073-MINSA/CDC V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de diarreas por rotavirus en niños/as menores de 5 años en hospitales centinelas". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/ROTAVIRUS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/FICHA-DE-ROTAVIRUS.pdf

Diarrea por Campylobacter

- **Enfermedad diarreica aguda acuosa:** Cuadro en el que el paciente presenta aumento en la frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez, y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos, y cuya duración es menor de catorce días.

- **Enfermedad diarreica aguda disentérica:** Cuadro en el que el paciente presenta aumento en la frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco.

Fuente: DS N°146-MINSA/CDC-2022 “Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por Campylobacter spp. En Hospitales Centinelas”. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/normas/CAMPYLOBACTER_DS%20N146-MINSACDC-2022.pdf

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/05/CAMPYLOBACTER_Formato-de-notificacion-individual-de-de-funciones-por-EDA.pdf

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

- **Asma bronquial en menores de 5 años:** Todo caso que se presente a partir de los 2 años de edad y menor de 5 años, que cursa con episodios de obstrucción bronquial, caracterizado por sibilancias o tos persistente, con presentación frecuentemente nocturna, con o sin dificultad respiratoria, única o recurrente, reversibles espontáneamente o con tratamiento.

- **Defunción intra-mural (conocida anteriormente como defunción intra-hospitalaria):** Todo caso de neumonía o infección respiratoria aguda grave, adquirida en la comunidad, que fallece en un establecimiento de salud, después de permanecer internado 24 horas o más. El diagnóstico de fallecimiento se deberá constatar con la historia clínica y/o con el certificado de defunción.

- **Defunción Extra - mural (conocida anteriormente como defunción extra-hospitalaria):** Todo caso de neumonía o Infección respiratoria aguda grave, adquirida en la comunidad que fallece en el domicilio, comunidad o en el establecimiento de salud con menos de 24 horas de internamiento. El diagnóstico de fallecimiento se deberá constatar con el certificado de defunción.

- **Hospitalización por neumonía:** Todo caso de cualquier edad, internado con diagnóstico de neumonía, neumonía grave o infección respiratoria aguda grave, con permanencia igual o mayor a 24 horas.

- **Infecciones Respiratorias Agudas (IRA):** Es toda infección que compromete una o más partes del aparato respiratorio y que tiene una duración menor de 14 días, causada por microorganismos virales, bacterianos u otros con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre.

- **Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG):** Síndrome caracterizado por aparición súbita de fiebre igual o superior a 38°C, tos o dolor de garganta más dificultad para respirar y que, por compromiso de su estado general debería ser hospitalizado

- **Infecciones respiratorias agudas de vías respiratorias altas en menores de 5 años:** Todo menor de 5 años que presente tos, acompañado de fiebre o rinorrea y que tiene una duración menor de 15 días, pero que no presenta dificultad respiratoria ni señales de alarma.

- **Neumonía:** Infección aguda del parénquima pulmonar causada por microorganismos virales, bacterianos u hongos.

- **Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC):** Trastorno inflamatorio del parénquima pulmonar que compromete alvéolos o intersticio causado por virus o bacterias, adquirida en el ambiente comunitario e incluyen aquellas diagnosticadas hasta las 48 horas de su hospitalización

- **Neumonía en menores de 5 años:** Todo caso en menores de 5 años que además de presentar tos, fiebre o rinorrea, presenta respiración rápida y/o dificultad respiratoria. En los establecimientos de salud de mayor complejidad además de los signos clínicos, el diagnóstico puede ser confirmado o descartado por evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar agudo compatible con neumonía.

- **Neumonía grave en menores de 5 años:** Todo episodio de neumonía en menores de 5 años, que además presente algún signo de alarma (Dificultad respiratoria severa, presencia de tiraje sub-costal, estridor o sibilantes, cianosis central, incapacidad para alimentarse o beber, vómitos persistentes, convulsiones, letargia o coma) o alguna complicación. En menores de 2 meses de edad se considerará caso grave todo caso de neumonía.

- **Neumonía en mayores de 5 años a más:** Todo paciente con diagnóstico clínico y/o radiológico de neumonía adquirida en la comunidad (Anexo 1), con un tiempo de enfermedad menor de 15 días.

- **Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB) en menores de 5 años:** Se utiliza esta definición en niños menores de 2 años que presenta sibilancias o tos persistente, con presentación frecuentemente nocturna, con o sin dificultad respiratoria, única o recurrente, que traduce una disminución de la luz bronquial.

Fuente: *DS N°061-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/IRA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/8.7-Ficha-Def-IRA-menor.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/07/8.8-Ficha-Def-IRA-mayor.pdf

Neumonía bacteriana

- **Caso sospechoso de neumonía:** Todo niño y niña menor de 5 años de edad hospitalizado con diagnóstico clínico de neumonía adquirida en la comunidad.

- **Caso probable de neumonía bacteriana:** Todo caso sospechoso de neumonía con una radiografía de tórax donde se identifique un patrón radiológico compatible con neumonía bacteriana.

- **Caso confirmado de neumonía bacteriana:** Todo caso probable de neumonía bacteriana en el cual se aísla Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae en la sangre y/o líquido pleural.

- **Caso de neumonía bacteriana descartado:** Todo caso probable de neumonía bacteriana con resultado negativo en sangre o líquido pleural o en el que se aísle un agente bacteriano diferente a Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.

Fuente: *DS N°074-MINSA/CDC V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Neumonías y Meningitis Bacterianas en niños y niñas menores de 5 años en Hospitales Centinela". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/04/RM_696-2016-Neumonia-y-meningitis-bacteriana-MINSA.pdf.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/05/NEUMONIA-BACTERIANA_Ficha-epidemiologica-de-neumonia-bacteriana-en-ninos-menores-de-5-anos.pdf

COVID-19

- **Caso sospechoso de COVID-19:** Persona que cumpla con al menos uno de los siguientes criterios:

  - Persona que presente tos y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos / síntomas:

    - Malestar general.
    - Fiebre.
    - Cefalea.
    - Congestión nasal.
    - Diarrea.
    - Anosmia.
    - Ageusia.

- **Caso probable de COVID-19:** Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios:

  - Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado o relacionado a un conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado.

  - Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de la COVID-19, en:

    - Radiografía de tórax: Opacidades nebulosas de morfología a menudo redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.
    - Tomografía computarizada de tórax: Múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior.
    - Ecografía pulmonar: Líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos.
    - Resonancia magnética: Daño miocárdico y evidencia de disfunción cardiaca asociada a la COVID-19.

- **Caso confirmado de COVID-19:** Persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios:

  - Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-CoV-2.

- Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2.

- Caso asintomático con prueba de PCR o una prueba de antígeno positiva para SARS-CoV-2.

- **Caso descartado:** Caso sospechoso o probable con evidencia clínica, radiológica o de laboratorio que explica otra etiología diferente a SARS-CoV-2.

Fuente: *NTS N°224-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), Fase Endémica en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/COVID_19.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/05/COVID-19_Ficha-de-investigacion-clinico-epidemiologica-COVID-19.pdf

Virus respiratorios (influenza, virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios)

- **Caso de Síndrome Gripal (SG) o Enfermedad Tipo Influenza (ETI):** Persona que presenta fiebre (mayor o igual a 38°C) de inicio brusco acompañado de tos o dolor de garganta. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como mialgias, postración, cefalea o malestar general.

- **Caso confirmado de influenza (estacional):** Persona con una prueba de laboratorio confirmatoria de infección con el virus influenza A o B en un laboratorio de referencia regional, en el Instituto Nacional de Salud (INS) o un laboratorio acreditado por el INS, con una o más de las siguientes pruebas:

  - Detección de antígeno por inmunofluorescencia (IF).
  - rt - PCR (Reacción en cadena de la polimerasa en transcripción reversa).
  - Cultivo viral.

  Incluye a todos los subtipos de virus de influenza que se transmiten entre los humanos: H1N1, H3N2 y el virus A(H1N1) pdm09.

- **Caso de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG):** Síndrome que se presenta en un paciente de cualquier edad, con aparición súbita de fiebre superior a 38°C o historia de fiebre y que presenta:

  - Tos.
  - Dificultad para respirar y
  - Que, por el compromiso de su estado general, deberá ser hospitalizado.

- **Evento inusitado:** Un evento es inusitado (inusual, atípico, o raro) cuando:

  - Es causado por un agente desconocido, o bien la fuente, el vehículo o la vía de transmisión son inusuales o desconocidos;
  - La evolución del caso es más grave de lo previsto o presenta síntomas o signos no habituales;
  - La manifestación del evento mismo resulta inusual para la zona, la estación o la población.

  Mediante su vigilancia se puede identificar los cuadros clínicos severos o atípicos, incluyendo la identificación de microorganismos emergentes.

- **Infección respiratoria aguda grave inusitada (inusual, atípica o rara) - IRAG inusitada:** Se considera caso de IRAG inusitada a:

  - Caso de IRAG en trabajador de salud con antecedente de contacto con personas con IRAG; o

- Caso de IRAG en personas previamente sanas de entre 5 a 60 años de edad; o
- Caso de IRAG en persona que ha viajado a áreas de circulación de virus de influenza con potencial pandémico; o
- Caso de IRAG de causa inexplicable en personas que trabajan con aves u otros animales; o
- Muerte por IRAG de causa desconocida.

- **Muerte relacionada con influenza:** Se considera muerte relacionada con influenza a una muerte que se presentó como consecuencia de una enfermedad clínicamente compatible con influenza y que se confirma por una prueba de laboratorio. No debe haber existido ningún periodo de recuperación completa entre la enfermedad y la muerte.

Fuente: *DS N°045-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, de otros Virus Respiratorios (OVR) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Directiva-Influenza-RM108-2012.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/8.3-Ficha-IRAG.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-IRAG-INUS.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/8.2-Ficha-SG.pdf

Meningitis meningocócica

- **Caso sospechoso de meningitis:** Todo niño y niña menor de 5 años hospitalizado con diagnóstico clínico de meningitis.

- **Caso probable de meningitis bacteriana:** Todo caso sospechoso de meningitis cuyo examen directo de líquido cefalorraquídeo (LCR) es compatible con meningitis bacteriana.

- **Caso confirmado de meningitis bacteriana:** Todo caso probable de meningitis bacteriana en que se aisló o identificó Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis en el líquido cefalorraquídeo o sangre.

- **Caso de meningitis bacteriana descartado:** Todo caso probable con resultado negativo en líquido cefalorraquídeo y sangre, o en el que se aísle un agente bacteriano diferente a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Neisseria meningltidis.

Fuente: *DS N°074-MINSA/CDC V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Neumonías y Meningitis Bacterianas en niños y niñas menores de 5 años en Hospitales Centinela". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/04/RM_696-2016-Neumonia-y-meningitis-bacteriana-MINSA.pdf.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/02/Ficha-NB-y-MB-anexo-12-14.pdf

Síndrome de Guillain Barré (SGB)

- **Caso sospechoso de síndrome de Guillain Barré (nivel de certeza III):** Persona de cualquier edad con debilidad muscular bilateral (ascendente o descendente), simétrica o relativamente simétrica y flacidez y reflejos osteotendinosos disminuidos o ausentes en extremidades y con 12 horas a 28 días de evolución desde el inicio de la debilidad muscular.

  Nota: Considerar variantes con debilidad facial bilateral y compromiso de movimientos oculares.

- **Caso confirmado de síndrome de Guillain Barré:** Caso sospechoso con al menos uno de los siguientes criterios:

  - Disociación albumino citológica en líquido cefalorraquídeo (Cifra total de leucocitos < 50 células/µl y elevación de proteínas > 45 mg/dl).

  - Estudio electrofisiológico compatible con SGB tomada entre la segunda y cuarta semana de inicio de la debilidad muscular.

  Nota: Se considerará nivel de certeza I si tiene ambas pruebas y nivel de certeza II si sólo cuenta con una de ellas.

  La punción lumbar debe realizarse antes de la administración de inmunoglobulina; si fue obtenida durante el tratamiento y el resultado no muestra la disociación albumino citológica, opcionalmente se puede obtener una segunda muestra en la segunda semana desde el inicio de la debilidad muscular.

- **Caso descartado de síndrome de Guillain Barré:** Caso sospechoso que durante la investigación tiene otro diagnóstico que explique el cuadro clínico, o que no cumpla con la definición de caso.

Fuente: *NTS N°175-MINSA/2021/CDC "Norma Técnica De Salud Para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio del Síndrome De Guillain Barré en el Perú". https://sgb.dge.gob.pe/uploads/documentos/sgb_norma_tecnica_NTS-N175-2021.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/sgb_ficha.pdf

Vigilancia epidemiológica de VIH/ITS/TB/IAAS

Gonorrea

- **Caso de gonorrea:** Toda persona con o sin sintomatología, que cumple al menos uno de los siguientes criterios de laboratorio, basado en una muestra clínica adecuadamente obtenida:

  - Detección microscópica de diplococos Gram negativos intracelulares.
  - Aislamiento de Neisseria gonorrhoeae, mediante cultivo en medio selectivo de Thayer-Martin.
  - Detección de ácido nucleico de Neisseria gonorrhoeae.

Fuente: *NTS N°115-MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en salud Pública de la Infección por el Virus de la Insuficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/NTS_115_2015_MINSA_DGE.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-investigacion-sifilis_gonorrea.pdf

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)

- **Caso de IAAS:** Se considera IAAS siempre que reúna los siguientes criterios:

  - Definición conceptual de IAAS.

  - Asociación del factor de riesgo vigilado (se afirma que la IAAS es potencialmente causada por un factor de riesgo, siempre y cuando no haya evidencia de alguna otra causa conocida) **Anexo N° 2 de la NTS N° 163-MINSA/2020/CDC.**

  - Criterios específicos según el tipo de IAAS (combinación de hallazgos clínicos, resultados de laboratorio y otras pruebas para cada tipo de IAAS) **Anexo N° 3 de la NTS N° 163-MINSA/2020/CDC.**

Fuente: *NTS N°163-MINSA/2020/CDC "Norma Técnica de Salud para la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/NTS_N163_IAAS_MINSA-2020-CDC.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/ANEXO-N5-FICHA-DE-INVESTIGACION-DE-IAAS-INDIVIDUAL.pdf

Sífilis

En población general (sífilis no especificada)

- **Caso probable de sífilis:** Toda persona que cumple al menos uno de los siguientes criterios:

  - Un resultado reactivo en una prueba de tamizaje para sífilis, con o sin evidencia clínica de sífilis primaria o sífilis secundaria.

  - Presencia de una o más úlceras genitales o extragenitales induradas (chancro duro), con antecedente de contacto con un caso confirmado de sífilis.

- **Caso confirmado de sífilis:** Toda persona que tenga al menos una prueba de tamizaje para sífilis reactiva (con títulos iguales o mayores a 8 diluciones) y con prueba confirmatoria reactiva, con o sin evidencia clínica de sífilis primaria o sífilis secundaria.

- **Caso descartado de sífilis:** Caso probable con prueba confirmatoria para sífilis negativa.

Sífilis materna

- **Caso probable de sífilis materna:** Toda mujer gestante, puérpera o con aborto reciente con un resultado reactivo en una prueba de tamizaje o pruebas rápidas para sífilis, con o sin evidencia clínica de sífilis primaria (úlcera genital, chancro duro) o lesiones compatibles con sífilis secundaria y que no ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación.

- **Caso confirmado de sífilis materna (Sífilis Activa):** Caso probable que tenga al menos una prueba tamizaje reactiva RPR o VDRL con títulos iguales o mayores a 8 diluciones Dils y prueba confirmatoria reactiva (FTA ABs TP PA).

- **Caso descartado de sífilis materna:** Caso probable con prueba rápida no reactiva o prueba de tamizaje reactiva (RPR o VDRL) cuantitativa, además de prueba confirmatoria no reactiva (FTA ABs TP PA).

Sífilis congénita: Caso que cumple al menos uno de los siguientes criterios:

- Producto de la gestación (recién nacido, mortinato o aborto espontáneo) de mujer con sífilis materna (activa) sin tratamiento o tratamiento inadecuado.

- Neonato con un resultado de títulos de análisis no treponémicos (RPR o VDRL cuantitativo) cuatro veces más altos que los títulos maternos o lo que equivale a un cambio en dos diluciones o más de los títulos maternos (por ejemplo, madre: 4 Dils (1:4) y niño: 16 Dils (1:16).

- Niño con una o varias manifestaciones clínicas sugestivas de sífilis congénita al examen físico o evidencia radiográfica de sífilis congénita y un resultado positivo de la prueba de tamizaje y/o confirmatoria (FTA-Abs-IgM).

- Niño mayor de 2 años de edad; con signos clínicos de sífilis secundaria en el que se ha descartado el antecedente de abuso sexual o contacto sexual.

- Demostración de Treponema pallidum en estudios histológicos, provenientes de lesiones, placenta, cordón umbilical o material de autopsia.

Fuente: *NTS N°115-MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/NTS_115_2015_MINSA_DGE.pdf*

DS N°062 MINSA/DGE V.01 2015 "Directiva Sanitaria N°062-MINSA-DGE V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Sífilis Materna y Sífilis Congénita". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-Miniterial-para-la-Vigilancia-de-sifilis-materna-y-congenita.pdf

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-investigacion-sifilis_gonorrea.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-de-investigacion-para-sifilis-materna-y-sifilis-congenita.pdf

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

- **Caso de infección por VIH en estadio SIDA:** Toda persona que cumple con los criterios de la definición de caso de infección por VIH y que según los criterios establecidos en la presente NTS es clasificado en estadio 3, o si se le diagnostica una enfermedad oportunista que define estadio SIDA.

Fuente: *NTS N°115-MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) en el Perú", aprobada por la Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/NTS_115_2015_MINSA_DGE.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/03/Ficha-notificacion-VIH.pdf

Tuberculosis (TB)

- **Caso nuevo de TB:** Persona con diagnóstico de TB que nunca ha recibido tratamiento anti-tuberculosis o que lo ha recibido por menos de 30 días consecutivos o 25 dosis continúas.

- **Caso nuevo de TB pulmonar con confirmación bacteriológicas:** Persona a quien se le diagnóstica TB con compromiso de parénquima pulmonar con baciloscopia (frotis) de esputo, cultivo o prueba molecular positiva.

- **Caso nuevo de TB pulmonar sin confirmación bacteriológicas:** Persona a quien se le diagnóstica TB pulmonar o extra pulmonar con frotis y cultivo negativos. Su diagnóstico se basa en criterio clínicos, epidemiológicos y por imágenes (Rx).

- **Caso TB extra-pulmonar:** Persona a quien se le diagnostica TB en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se base en cultivo, prueba molecular positiva, evidencia histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad extra-pulmonar activa.

- **Caso de TB resistente a rifampicina (TB RR):** Caso de TB con prueba de sensibilidad (convencional o por pruebas rápidas) con resistencia solo a Rifampicina.

- **Caso de TB multidrogorresistente (TB MDR):** Caso de TB con prueba de sensibilidad (convencional o por pruebas rápidas) con resistencia simultánea a Isoniacida y Rifampicina.

- **Caso de TB extensamente resistente (TB XDR):** Caso de TB con prueba de ensibilidad (convencional o molecular) con resistencia simultánea a Isoniacida,Rifampicina, una Fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea (Amikacina, Kanamicina o Capreomicina).

- **Caso de TB monorresistente:** Caso de TB con resistencia solamente a un medicamento anti-tuberculosis, demostrada a través de una prueba de sensibilidad convencional.

- **Caso de TB polirresistente:** Caso de TB con resistencia a más de un medicamento anti-tuberculosis sin cumplir criterio de TB MDR, demostrada a través de una prueba de sensibilidad convencional.

- **Caso de TB abandono recuperado:** Caso de TB de cualquier localización que no concurrió a recibir tratamiento por más de 30 días consecutivos, es dado de alta como abandono y es captado nuevamente por el establecimiento de salud (EESS) para reiniciar tratamiento desde la primera dosis.

- **Caso de TB recaída:** Caso de TB de cualquier localización, que presenta otro episodio de TB diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado o como tratamiento terminado.

- **Caso de TB en personal de salud:** Caso de TB diagnosticado en una persona que trabaja en un establecimiento de salud.

- **Evento de Importancia en Salud Pública (EVISAP) relacionado con TB:** Todo evento que pone en riesgo u ocasiona daño a una determinada población, de tal magnitud que altera su normal desenvolvimiento, requiriendo una respuesta extraordinaria de los servicios de salud los EVISAP relacionados con TB podían ser los siguientes:

  - Dos o más casos de Tb en poblaciones cerradas.

  - Un caso de TB pulmonar en frotis positivo en una población cerrada.

  - Caso de TB pulmonar frotis positivo que viajaron en medios de transporte internacionales.

Fuente: D*S N°079-MINSA/2017/CDC "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Directiva_de_TB.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Fichas_TB.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Fichas_TB_TS.pdf

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

- **Caso de infección por VIH**

  - En personas mayores de 18 meses de edad, y en menores de 18 meses sin evidencia de transmisión madre-niño: Se considerará caso de VIH, con fines de vigilancia epidemiológica que deberá ser notificado, si cumple con alguno de los siguientes 3 criterios:

    - Dos pruebas diagnósticas para VIH reactivas o positivas.

    - Un resultado positivo o una cantidad detectable (según límites establecidos de la prueba), en una prueba confirmatoria de tipo virológica para VIH (que detecta o aísla material genético del VIH).

    - Una prueba de tamizaje reactiva asociada a la presencia de al menos una enfermedad oportunista que define estadio SIDA (Anexo 1), que no pueda ser explicada por otra condición.

  - **En menores de 18 meses de edad, nacidos expuestos al VIH:** Se considerará caso de VIH si cumple con la definición de Caso de niño nacido expuesto al VIH y además cumple alguno de los siguientes criterios:

    - Tener dos resultados positivos de PCR-ADN-VIH-1, a partir de muestras tomadas con al menos 30 días de diferencia (en muestras sanguíneas que no provengan de cordón umbilical). De no contar con lo anterior, los resultados positivos también pueden corresponder a las siguientes pruebas virológicas: Prueba de antígeno p24 para VIH-1, aislamiento del VIH (cultivo viral) o PCRARN- VIH-1).

    - Niño con enfermedad oportunista que define estadio SIDA (Anexo 1 de documento normativo).

- **Caso de niño nacido expuesto al VIH:** Todo niño menor de 18 meses de edad, que haya nacido de madre infectada por el VIH o que tenga un resultado positivo en una prueba de anticuerpos para VIH si el estado serológico de la madre es desconocido.

- **Caso de niño nacido expuesto y no infectado por el VIH:** Todo niño nacido de madre infectada por VIH o que antes de los 18 meses de edad tenga un resultado positivo en una prueba de anticuerpos para VIH, y que además cumpla con alguno de los siguientes criterios:

  - Niño menor de 18 meses de edad, con dos PCR DNA VIH-1 negativas en dos determinaciones separadas.

  - Niño > 18 meses de edad, con prueba de anticuerpos para VIH no reactiva.

- **Caso de gestante con infección por VIH:** Toda mujer gestante, puérpera o con aborto reciente, con diagnóstico de infección por VIH previo a la gestación, o que cumple con los criterios de Caso de infección por VIH durante la gestación.

- **Caso de infección por VIH en estadio avanzado:** Toda persona que cumple con los criterios de la definición de caso de infección por VIH y que según los criterios establecidos en la presente NTS, es clasificado en estadio 2.

- **Caso de fallecido con VIH o SIDA:** Toda persona con infección por VIH que fallece por cualquier causa. O toda persona que fallece sin diagnóstico previo de SIDA y que en la necropsia se evidencia alguna enfermedad indicadora.

- **Caso de infección por VIH que inicia TARGA:** Toda persona que cumple con los criterios de la definición de caso de infección por VIH, que inicia tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA).

Fuente: N*TS N°115-MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) en el Perú", aprobada por la Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/NTS_115_2015_MINSA_DGE.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/03/Ficha-notificacion-VIH.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/03/Ficha-investigacion-de-la-gestante-y-el-nino-expuesto-al-VIH.pdf

Vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunas

Difteria

- **Caso probable de difteria:** Todo caso sospechoso que presenta membrana adhesiva en las amígdalas, la faringe o la nariz.
- **Caso sospechoso de difteria:** Todo caso que presenta molestia en la faringe y dificultad o dolor para deglutir.
- **Caso confirmado de difteria:** Todo caso probable con uno de los siguientes criterios:
  - Aislamiento de Corynebacterium diphtheriae de un espécimen clínico.
  - Aumento al cuádruple o más de los anticuerpos séricos (pero solo sí ambas muestras séricas se obtuvieron antes de la administración de toxoide diftérico o antitoxina).
  - Diagnóstico histopatológico de la difteria.
  - Por nexo epidemiológico a un caso confirmado por laboratorio.

Fuente: *Alerta Epidemiológica N°024-2020 "Riesgo de transmisión de Difteria ante la confirmación de un caso en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/alertas/alertas_202024.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/FICHA-DIFTERIA.pdf

Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) Severo

- **Caso de ESAVI severo:** Es todo ESAVI que cumpla uno o más de los siguientes criterios:
  - Hospitalización.
  - Riesgo de muerte.
  - Discapacidad.
  - Fallecimiento.

Fuente: *DS N°054-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI)". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-ESAVI08-04-ESAVI.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/ESAVI_NI_Anx01.pdf

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/ESAVI_FI.pdf

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/ESAVI_LCH.pdf

Fiebre amarilla

- **Caso probable de fiebre amarilla:** Toda persona de cualquier edad procedente de zona endémica de fiebre amarilla, con fiebre de inicio súbito hasta 07 días de evolución, seguido de ictericia, que reside 0 ha visitado zonas endémicas en los últimos 14 días, con 0 sin vacunación contra fiebre amarilla y que presenta una 0 más de las siguientes manifestaciones clínicas:

  - Escalofríos.
  - Cefalea intensa.
  - Dolor lumbar.
  - Mialgias.
  - Postración.
  - Congestión facial / conjuntival.
  - Náuseas y vómitos.
  - Sangrado.
  - Muerte después de haberse instalado la enfermedad con compromiso de un órgano o sistema (falla renal, hepática, otros).

- **Caso confirmado de fiebre amarilla**

  Por laboratorio: Todo síndrome febril o caso probable cuyo resultado de laboratorio es positivo por uno o más de los métodos siguientes:

  - **En suero**
    - Aislamiento del virus de la fiebre amarilla.
    - Presencia de IgM específica para fiebre amarilla.
    - qRT-PCR para fiebre amarilla.
    - Evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadas, la segunda muestra deberá ser tomada después de los 14 días del inicio de síntomas (en zonas donde hay transmisión).
    - Detección de anticuerpos de neutralización para fiebre amarilla.
  - **En tejidos**
    - Inmunohistoquímica especifica (postmortem).

- qR T-PCR para fiebre amarilla.

- **Por nexo epidemiológico**

  - Contacto de uno o más casos sospechosos con uno o más casos confirmados, procedentes de la misma área endemo – enzoótica.

  - Contacto de un caso sospechoso que fallece en menos de 10 días, sin confirmación por laboratorio y que provenga de área donde hay casos confirmados.

- **Caso descartado de fiebre amarilla:** Todo caso probable en el que después de la investigación epidemiológica se encuentre lo siguiente:

  - Antecedente vacunal con evidencia de seroconversión.

  - Pruebas de laboratorio negativas para fiebre amarilla.

  - Ausencia de nexo epidemiológico.

  - Evidencia de otro diagnóstico alternativo, confirmado por laboratorio.

Fuente: *PSU N°16-MINSA/DVMSP/DGIESP Protocolo Sanitario de Urgencia para el Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Fiebre Amarilla". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/08/protocolo-sanitario-urgencia-fiebre-amarilla-pe-ru.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_amarilla.pdf

Hepatitis B

- **Caso probable de hepatitis B aguda:** Es todo caso con aparición de una enfermedad aguda inespecífica, con signos y síntomas de infección (por ejemplo: fiebre, malestar general y cansancio) y daño hepático, que puede ser clínico (por ejemplo: anorexia, náuseas, ictericia, coluria, dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho), o aumento de la concentración de ALT de más de 10 veces el límite superior del intervalo de referencia.

- **Caso confirmado de hepatitis B aguda:** Es todo caso que cumple el criterio clínico de Hepatitis aguda y cuenta con confirmación de laboratorio de infección reciente de VHB, es decir Anti IgM HBc positivo.

- **Caso de infección crónica por el virus de la hepatitis B:** Es todo caso con ausencia de Hepatitis aguda y la presencia del HBsAg (antígeno de superficie) por más de seis meses o por presentar la Anti IgM HBc negativo más HBsAg positivo más Anti HBc Total positivo.

Fuente: *NTS N°146-MINSA/2018/DGIESP "Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis Viral B en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/08/HEPATITIS-B_Resolucion_Ministerial_N__1330-2018-MINSA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/FICHA-HEPATITIS-B.pdf

Parálisis Flácida Aguda (PFA)

- **Caso de parálisis flácida aguda:** Persona menor de 15 años que presenta pérdida o disminución de la fuerza muscular (parálisis o paresia), disminución o ausencia de tono muscular (hipotonía) y disminución o ausencia de reflejos (hipo o arreflexia), con una instalación aguda de curso progresivo o rápidamente progresivo sin asociación a trauma previo.

- **Caso confirmado de poliomielitis:** Es todo caso de parálisis flácida aguda asociada al aislamiento de poliovirus salvaje o de poliovirus derivado de vacuna (PVDV), con parálisis residual o sin ella.

- **Caso de poliomielitis por poliovirus salvaje:** Es todo caso de parálisis flácida aguda en el que se aísla el poliovirus salvaje en muestra de heces.

- **Caso de poliomielitis por poliovirus derivado de vacuna:** Es todo caso de parálisis flácida aguda en el que se ha aislado poliovirus derivado de vacuna en la muestra de heces.

- **Caso de poliomielitis paralítica asociado a vacuna (PPAV):** Es todo caso de parálisis flácida aguda cuyo origen se atribuye al virus de la vacuna oral contra la poliomielitis (VOP), y donde se han excluido otras causas. Los casos asociados a la vacuna deben separarse de los casos de poliomielitis por poliovirus salvaje o por poliovirus derivado circulante. Para clasificar un caso como asociado a la vacuna han de reunirse los siguientes requisitos:

  - En vacunados: caso de parálisis flácida aguda (PFA) que inicia la parálisis entre 4 y 40 días después de recibir la vacuna oral contra la poliomielitis (VOP).

  - En contactos de vacunados: caso de parálisis flácida aguda (PFA) que inicia la parálisis entre 4 a 40 días posterior al contacto con una persona que recibió la vacuna oral contra la poliomielitis (VOP) entre 4 a 85 días previo al inicio de la parálisis.

  - Debe haberse aislado el poliovirus vacunal en la muestra de heces.

  - Debe haber secuela neurológica compatible con poliomielitis a los 60 días de iniciada la parálisis flácida aguda.

- **Caso compatible con poliomielitis:** Es todo caso de parálisis flácida aguda con parálisis residual compatible con poliomielitis a los 60 días de seguimiento y sin evidencia de otra patología; o bien falta de seguimiento o defunción, en la que no se obtuvo una muestra de heces durante los primeros 15 días siguientes al comienzo de la parálisis.

- **Caso descartado de poliomielitis:** Es todo caso de parálisis flácida aguda con muestra de heces dentro de los 14 días posteriores al inicio de la parálisis en la cual no se aísla poliovirus salvaje o derivado. Los casos que no tengan una muestra de heces y no presenten parálisis residual compatible con poliomielitis a los 60 días serán evaluados por la Comisión Nacional Revisora de Casos de Parálisis Flácida Aguda.

Fuente: *DS N°059-MINSA/DGE – V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/directiva-sanitaria-de-polio.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_pfa.pdf

Parotiditis

- **Caso probable:** Toda persona con dolor a la palpación y/o aumento de volumen (hinchazón) en región de glándulas parótidas (unilateral o bilateral), que dura 2 o más días (generalmente hasta 10 días) con o sin fiebre.

- **Caso confirmado**

  - **Caso confirmado por clínica:** Todo caso probable evaluado por una persona de salud.

  - **Caso confirmado por nexo epidemiológico:** caso probable que estuvo expuesto a un caso confirmado por clínica o laboratorio durante su periodo de transmisibilidad.

- **Caso confirmado con complicaciones:** Todo caso confirmado de parotiditis que presenta los siguientes diagnósticos: orquitis (hombres), mastitis u ooforitis (mujeres), disminución o pérdida de la audición, meningitis aséptica, encefalitis, pancreatitis o alguna otra condición con compromiso del estado general que requiera hospitalización; y en el contexto de brote o epidemia con un resultado positivo a una prueba de laboratorio.

- **Caso descartado:** Todo caso probable que en la investigación epidemiológica y evolución clínica no cumple con los criterios: clínico, epidemiológico o laboratorial según corresponda, y/o en quien se confirma otra etiología.

- **Caso sospechoso:** Toda persona que al examen clínico o evaluación del área bucal u odontológica presenta dolor en la región parotídea a la apertura amplia bucal y/o inflamación o enrojecimiento en la salida del conducto de Stenon.

Fuente: *Alerta Epidemiológica N°013-2019 "Incremento de brotes de parotiditis en poblaciones de entorno cerrado a nivel nacional". https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2019/AE013.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/parotiditis_cc.pdf

Sarampión - Rubéola (SR)

- **Caso sospechoso de sarampión/rubéola:** Toda persona de cualquier edad, de quién un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubéola, o en todo caso que presente fiebre y erupción maculopapular generalizada. NO vesicular.

- **Caso confirmado:** Un caso sospechoso de sarampión o rubéola que se confirma por cualquiera de las siguientes situaciones:

  - **Por criterio clínico, epidemiológico y laboratorial:** Debe cumplir los tres criterios.

    - **Por aislamiento viral:** Del virus sarampión o rubéola en muestras de hisopado nasal y faríngeo

    - **Por nexo epidemiológico a otro caso confirmado.**

    - **Por clínica:** Es un caso sospechoso que no se ha investigado adecuadamente, por cualquiera de las siguientes razones:

      - El paciente murió antes de que se concluyera la investigación,

      - El paciente no pudo ser localizado,

      - El paciente se perdió durante el seguimiento.

- **Caso descartado:** Es un caso sospechoso que ha sido objeto de una investigación completa y que no cumple con los criterios clínico, epidemiológico laboratorial, el aislamiento viral es negativo y no tiene nexo epidemiológico.

- **Caso importado:** Un caso importado de sarampión o rubéola es el caso en quien se ha confirmado la infección y que la investigación epidemiológica y las pruebas virológicas demuestran que estuvo expuesto fuera del continente americano o del país durante los 7 a 21 días anteriores al inicio del exantema, para el caso de sarampión, y de 12 a 23 días, para el caso de rubéola. Los resultados de la secuenciación molecular del virus aislado en estos casos deben ser compatibles con los que circulan en el país de procedencia donde probablemente ocurrió la infección.

- **Caso relacionado con importación:** Es un caso confirmado que según la investigación epidemiológica y las pruebas virológicas estuvo expuesto localmente al virus, formando parte de la cadena de transmisión iniciada por un caso importado.

- **Caso confirmado con fuente de infección desconocido:** Es un caso confirmado en el que no se pudo detectar la fuente de infección.

- **Caso confirmado asociado a la vacuna:** Es cuando cumple con los cinco criterios que se indican a continuación:

  - El exantema apareció 7 a 14 días después de la vacunación SPR / SR.

- El paciente tuvo enfermedad exantemática con o sin fiebre, pero no presentó tos u otros síntomas respiratorios que acompañen al exantema.

- La investigación epidemiológica exhaustiva no logró detectar un caso primario ni casos secundarios.

- La muestra de sangre, que contenía anticuerpos IgM especificaos, se obtuvo entre los 8 y 56 días después de la vacunación.

- El resultado de aislamiento viral confirma que es un virus vacunal no salvaje.

Fuente: *DS N°049-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de sarampión, rubéola y otras enfermedades febriles eruptivas". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/directiva-sanitaria-de-sr.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_srubeola.pdf

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

- **Caso sospechoso de SRC:** Todo niño menor de 1 año al cual:

  - Se le ha detectado una o más de las siguientes anormalidades: catarata/glaucoma congénito, retinopatía pigmentaria, microftalmia, déficit de la audición, cardiopatía congénita (las más frecuentes son: persistencia del conducto arterioso, estenosis arteria-pulmonar, comunicación interventricular, comunicación interauricular, entre otras), púrpura, trombocitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia, microcefalia, meningoencefalitis, enfermedad ósea radiotransparente, retraso en el desarrollo psicomotor, ictericia (dentro de las 24 horas, después del nacimiento) Y/O

  - Madre que cuente con historial de infección por rubéola (confirmada o sospechosa) durante el embarazo.

Nota: Los lactantes que nacieron con bajo peso deben ser examinados con rigurosidad en busca de algún defecto congénito descrito en la definición de caso sospechoso para SRC.

- **Caso confirmado de SRC**

  - **Caso confirmado por laboratorio:** caso con signos clínicos asociados al SRC y resultado positivo en una de las siguientes pruebas de laboratorio:

    - Identificación de anticuerpos IgM específicos para rubéola en muestra de suero.

    - Persistencia o incremento del título de anticuerpos IgG específicos para rubéola en una segunda muestra de suero obtenida a los 6 meses de edad.

    - Detección del virus de la rubéola mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o aislamiento viral a partir de muestras de hisopado nasofaríngeo.

- **Caso confirmado por criterios clínicos:** caso sospechoso de SRC que no está confirmado por criterio de laboratorio (carece de muestra de laboratorio o es una muestra inadecuada) y que no evidencia otra etiología.

Todo caso sin muestra es considerado una falla del sistema de vigilancia.

- **Infección congénita por el virus de la rubéola:** Niño menor de un año con resultado positivo de anticuerpos IgM específicos para rubéola pero que no presenta ninguna manifestación clínica de SRC. El menor debe ser evaluado para descartar la deficiencia auditiva a través de un procedimiento adecuado.

Fuente: *Alerta Epidemiológica N°001-2024 "Riesgo de presentación de casos importados de Sarampión-Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita a nivel nacional". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/alertas/alertas_20241_26_152139.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_src.pdf

Tétanos

- **Caso probable de tétanos:** Característica clínica, de inicio agudo, con rigidez (hipertonía) y /o contracciones musculares dolorosas, inicialmente de los músculos de la mandíbula y del cuello (trismus) y espasmos musculares generalizados, sin otra causa médica aparente.

- **Caso confirmado de tétanos:** Caso clínicamente compatible reportado por un profesional de salud.

Fuente: *Compendio de Definiciones de Caso de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/compendio_dc.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_tetanos.pdf

Tétanos neonatal

- **Caso probable de tétanos neonatal**

  - Todo recién nacido que haya tenido una enfermedad con las características del tétanos o que presenta incapacidad para succionar, que ha llorado y se ha alimentado normalmente durante los dos primeros días de vida.

  - Todo fallecimiento neonatal entre los 3 a 28 días de vida por una causa no conocida, en un niño que succionaba y lloraba normalmente durante las primeras 48 horas de vida.

- **Caso confirmado de tétanos neonatal:** Todo recién nacido con historia de alimentación y llanto normal durante los 2 primeros días de vida, comienzo de la enfermedad entre el día 3 y 28 de vida e incapacidad para la succión (presencia de trismus) seguida de rigidez muscular generalizada y/o convulsiones (espasmos musculares).

- **Caso descartado de tétanos neonatal:** Un caso descartado es aquel que ha sido investigado y no cumple con la definición de caso, se debe especificar el diagnóstico.

Fuente: *Compendio de Definiciones de Caso de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica. https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/compendio_dc.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_tetano_neonatal.pdf

Tos ferina

- **Caso probable:** Toda persona:

  - Menor de un año de edad, que inicie con tos de cualquier duración, sin otra causa aparente acompañado de uno o más de los siguientes signos:

    - Tos paroxística
    - Estridor respiratorio
    - Vómito después de toser o vómitos sin otra causa aparente.
    - Apnea.

  - **Mayor o igual a un año,** que presente tos por dos semanas a más de duración, o de cualquier duración en el contexto de un brote, sin otro diagnóstico probable, acompañado de uno o más de los siguientes signos:

    - Tos persistente (accesos de tos).
    - Estridor inspiratorio.
    - Vómitos después de toser o vómitos sin otra causa aparente.
    - Sospecha del personal de salud a tos ferina.

  - **Adolescente, jóvenes, adultos y adultos mayores** pueden presentar algunos de los signos y síntomas antes descritos; frecuentemente presentan un cuadro subclínico, con aparente buen estado general, caracterizado por: Tos nocturna y/o tos al estímulo de la región traqueal por palpación externa. En caso de no presentar nexo epidemiológico, la sospecha de tos ferina debe realizarse después de descartar tuberculosis pulmonar u otro diagnóstico aparente (ej. asma).

- **Caso confirmado:** Cualquier persona considerada como caso probable:

  - **Por pruebas de laboratorio**, persona considerada como caso probable con resultado positivo a: Aislamiento de Bordetella pertussis (Cultivo) o PCR en tiempo real

  - **Por nexo epidemiológico**

    - Cualquier persona considerada como caso probable que ha estado en contacto directo con un caso confirmado mediante pruebas de laboratorio (o con un caso confirmado por nexo epidemiológico en el contexto de un brote), donde el periodo de exposición del caso probable coincide con el periodo de transmisibilidad del caso confirmado.

- Cualquier persona considerada como caso probable que ha sido identificado en la investigación epidemiológica retrospectiva y que antecede a un caso confirmado por laboratorio, cuyo periodo de transmisibilidad coincide con el periodo de exposición del caso confirmado, y forma parte de un conglomerado (familia, colegio, trabajo, establecimiento de salud, etc.). Es el caso del cual se pudo haber contagiado el caso confirmado.

- **Caso descartado:** Persona considerada como caso probable en el que se documentó otro diagnóstico o que, durante la investigación epidemiológica, se obtuvieron muestras en condiciones adecuadas y con resultados de PCR o aislamiento negativo. Un resultado negativo de PCR o aislamiento no descarta el caso cuando la muestra no ha sido obtenida en condiciones adecuadas.

- **Caso sospechoso:** En el contexto de brote, considerar a todo caso con tos de cualquier duración que forma parte de un conglomerado relacionado en espacio y tiempo.

Fuente: *NTS N°206-MINSA/CDC-2023 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Tos Ferina". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/TOS_FERINA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_tosf.pdf

Varicela

- **Caso de varicela: T**odo caso que presente exantema máculo pápulo vesicular que evoluciona a costras (con polimorfismo regional), de presentación céfalo caudal, muy pruriginosa, con o sin fiebre.

- **Caso de varicela complicada:** Es aquel caso de varicela, que además presenta cualquiera de las siguientes manifestaciones:

  - Sobreinfecciones de piel y partes blandas (impétigo, celulitis, absceso, fascitis necrotizante, paniculitis, otras)

  - Neurológicas (cerebelitis, encefalitis, meningitis, mielitis, síndrome de Guillain Barré),

  - Respiratoria (neumonitis, neumonías),

  - Hematológicas (síndrome hemorrágico),

  - Visceral o diseminada (miocarditis, pericarditis, hepatitis, nefritis),

  - Otras complicaciones: Síndrome de Reye, o

  - Que, por el compromiso del estado general, requiera hospitalización.

Fuente: *Alerta Epidemiológica N°011-2017 "Ante incremento estacional de casos de varicela en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portal/docs/alertas/2017/AE011.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/varicela_cc.pdf

Mpox (viruela símica)

Las siguientes definiciones de caso de Mpox se utilizarán independientemente si la persona ha presentado un diagnóstico confirmado a Mpox previamente:

- **Caso sospechoso**

  i) Persona quien es contacto de un caso probable o confirmado de Mpox en los 21 días previos al inicio de la enfermedad y que presenta uno o más de los siguientes signos o síntomas prodrómicos: fiebre (>=38°C oral), cefalea, mialgia (dolor muscular/dolor de cuerpo), dolor de espalda, astenia o debilidad.

  ii) Una persona que presenta un exantema agudo inexplicable con lesiones en piel o mucosas; que puede presentar linfadenopatía (nódulos linfáticos inflamados).

  El exantema puede incluir lesiones únicas o múltiples en la región anogenital o en otras partes del cuerpo.

  Las lesiones de la mucosa pueden incluir lesiones orales, conjuntivales, uretrales, peneanas, vaginales o anorrectales únicas o múltiples.

  Las lesiones anorrectales también pueden manifestarse como inflamación anorrectal (proctitis), dolor y/o sangrado.

  Exantema agudo inexplicable: causas comunes que no explican completamente el cuadro clínico, Ejm: varicela zoster, herpes zóster, herpes simple, infecciones cutáneas bacterianas, infección gonocócica diseminada, sífilis primaria o secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso y cualquier otra enfermedad común y relevante en la región que genere erupción papular o vesicular. No es necesario obtener resultados de laboratorio negativos para estas causas, si la sospecha de infección por Mpox, el descarte de otro patógeno no debe impedir el descarte de Mpox, por posibles coinfecciones.

- **Caso probable**

  i) Una persona que presenta un exantema agudo inexplicable con lesiones en piel o mucosas; que puede presentar linfadenopatía (nódulos linfáticos inflamados).

  El exantema puede incluir lesiones únicas o múltiples en la región anogenital o en otras partes del cuerpo.

  Las lesiones de la mucosa pueden incluir lesiones orales, conjuntivales, uretrales, eneanas, vaginales o anorrectales únicas o múltiples.

  Las lesiones anorrectales también pueden manifestarse como inflamación anorrectal (proctitis), dolor y/o sangrado.

  Y

ii) Uno o más de los siguientes criterios:

- Tiene un contacto directo con un caso probable o confirmado de Mpox en los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas.

- Pertenece a un grupo de mayor riesgo o se identifica como homosexual, bisexual u hombre que tiene sexo con hombres (HSH).

- Ha tenido parejas sexuales múltiples y/o ocasionales en los 21 días anteriores a la aparición de los síntomas

- Tiene contacto con materiales contaminados (ropa, sábana, material lab.) o exposición sin protección respiratoria u ocular con un caso probable o confirmado en los últimos 21 días anteriores al inicio de los síntomas o exantema.

- **Caso confirmado:** La confirmación de caso de Mpox se realiza por resultado de laboratorio de prueba molecular.

- **Caso descartado:** Persona que no cumple con los criterios clínicos o epidemiológicos o se identificó el agente etiológico causante del exantema agudo y/o tiene resultado de laboratorio negativo para el virus mediante prueba molecular (PCR).

Fuente: *Alerta Epidemiológica N°009-2024 "Actualización de la Alerta por el riesgo de Introducción del Clado Ib de Mpox en el Perú" . https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/alertas/alertas_20249_06_082723.pdf*

NTS N°195-MINSA/CDC-2022 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Viruela del Mono (Viruela Símica) en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/MPOX.pdf

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_vmono.pdf

Vigilancia epidemiológica de enfermedades metaxénicas

Chikungunya

- **Caso probable de chikungunya:** Se denomina así a la persona con fiebre de inicio brusco, que presente artralgia intensa o poliartralgia bilateral o artritis de comienzo agudo que no es explicada clínicamente por otra condición médica, con un tiempo de evolución menor o igual a 7 días, que reside o ha visitado áreas con transmisión de chikungunya o con infestación del vector *Aedes aegypti*, dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas y que presente una de las siguientes manifestaciones:

  - Mialgias.
  - Cefalea.
  - Rash o exantema (aproximadamente a partir del segundo al tercer día de enfermedad).

- **Caso probable de chikungunya grave:** Se denomina así a la persona como probable a chikungunya y que presente la falla de, al menos, un órgano o sistema o alguna manifestación atípica como:

  - Sistema nervioso: Meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré (SGB), síndrome cerebeloso, paresia, parálisis y neuropatías.
  - Ojo: Neuritis óptica, iridociclitis, epiescleritis, retinitis y uveitis.
  - Cardiovascular: Miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardiaca, arritmia e instabilidad hemodinámica.
  - Piel: Hiperpigmentación par fotosensibilidad, dermatosis vesiculobulosa y ulceraciones aftosas.
  - Riñones: Nefritis y la insuficiencia renal aguda.
  - Otros: Coagulopatía, neumonía, insuficiencia respiratoria, hepatitis, pancreatitis y la insuficiencia suprarrenal

- **Caso confirmado de chikungunya:** Se denomina así a la persona considerada como probable a chikungunya y que tenga, al menos, una de las siguientes pruebas confirmatorias de laboratorio:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
  - Evidencia de seroconversión en ELISA IgM en muestras pareadas en aquellos casos en zonas donde no hay transmisión de chikungunya. Para una mejor identificación de anticuerpos, la segunda muestra debe ser tomada a los 14 días desde el inicio de síntomas y, como máxima, hasta los 30 días desde el inicio de síntomas.

- ELISA IgM para chikungunya, para aquellos casos que cumplan con la definición de caso probable de chikungunya en zona endémica o este dentro de un contexto de brote o epidemia de chikungunya.

- Aislamiento viral por cultivo celular u otros sistemas biológicos.

- Histopatología e inmunohistoquímica de tejido.

- Confirmación par nexo epidemiológico, solo en situación de brote o epidemia donde se ha comprobado la circulación del virus chikungunya y no se confirme circulación simultanea de otras arbovirus en la misma temporalidad y espacio.

• **Caso descartado de chikungunya:** Se denomina así a la persona que fue considerada como probable a chikungunya y que cumple con alguno de los siguientes criterios:

a) Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y resultados negativos de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad por las siguientes pruebas de diagnóstico:

   - Prueba molecular.

   - Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.

   - En caso de ELISA IgM para chikungunya en una sola muestra con tiempo de enfermedad mayor igual a 14 días desde el inicio de síntomas.

   - Evidencia de seroconversión en ELISA IgM para chikungunya en muestras pareadas.

b) Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable.

c) Identificación por laboratorio de otro agente causal.

Fuente: *NTS N°230-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2025_14_100517.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_arbovirosis.pdf

Dengue

- **Caso probable de dengue sin signos de alarma:** Toda persona con fiebre menor o igual a 7 días de evolución, que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infestación del vector *Aedes aegypti* dentro de los 14 días antes del inicio de síntomas, y que presenta al menos 2 de las siguientes manifestaciones:

  - Cefalea.
  - Mialgias.
  - Artralgia.
  - Dolor ocular o retro ocular.
  - Nauseas/vómitos.
  - Rash/exantema (aproximadamente a partir del quinto día de enfermedad).

El hallazgo de leucopenia en un hemograma aumenta la probabilidad de estar frente a un caso de dengue. Sin embargo, si el paciente cumple con la definición de caso probable para dengue debe ser “manejado clínicamente como dengue” y no esperar algún resultado de laboratorio.

En niños, se considera caso probable de dengue sin signos de alama a todo niño con fiebre sin foco aparente menor o igual a 7 días de evolución, que reside o ha visitado áreas de transmisión de dengue o con infestación del vector Aedes aegypti dentro de los 14 días antes del inicio de síntomas.

Nota: Para el llenado de la ficha clínico epidemiológica y su notificación no es necesario esperar resultados de laboratorio.

- **Caso probable de dengue con signos de alarma:** Toda persona considerada como probable a dengue y que adicionalmente presenta una o más de las siguientes manifestaciones:

  - Dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación del abdomen.
  - Vómitos persistentes.
  - Sangrado de mucosas y/o piel de cualquier tipo: Gingivorragia, epistaxis, metrorragia, hipermenorrea y hematomas.
  - Letargia, inquietud o irritabilidad.
  - Derrame seroso al examen clínico o por estudio de imágenes (ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico).
  - Lipotimia.
  - Hepatomegalia (mayor de 2 cm por debajo del reborde costal derecho).

- Aumento progresivo del hematocrito.

- **Caso probable de dengue grave:** Toda persona considerada como probable a dengue y que adicionalmente presenta, por lo menos, uno de los siguientes signos:

  - Signos de cheque hipovolémico*.

  - Síndrome de dificultad respiratoria debido a extravasación importante de plasma.

  - Sangrado grave, según criterio clínico (de acuerdo a la evaluación del médico tratante), ejemplo: Hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central.

  - Compromiso grave de órganos:

    - Miocarditis.

    - En el sistema nervioso central: Encefalitis, trastorno de la conciencia, escala de Glasgow menor de 15, convulsiones.

    - Hepatitis: TGO, TCP ≥ 1000 UI.

    *Se considera choque hipovolémico si cumple con alguna de las siguientes manifestaciones: Presión diferencial de la presión arterial ≤ 20 mmHg, pulso rápido y débil o indetectable (pulso filiforme), frialdad de extremidades o cianosis, llenado capilar > 2 segundos y taquicardia. La hipotensión debe considerarse un signo tardío del choque.

- **Caso confirmado de dengue:** Toda persona considerada como probable a dengue y que cumpla con uno de los siguientes criterios:

  a) Resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas de laboratorio:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).

  - ELISA Antígeno NSI.

  - ELISA IgM para dengue, para aquellos casos que cumplan con la definición de caso para dengue en zona endémica o esté dentro de un contexto de brote o epidemia de dengue.

  - Evidencia de seroconversión de ELISA IgM en muestras pareadas en aquellos casos en zonas donde no hay transmisión de dengue. Para una mejor identificación de anticuerpos, la segunda muestra debe ser tomada a los 14 días del inicio de síntomas y no debe exceder los 30 días desde el inicio de síntomas.

  - Aislamiento viral en cultivo celular u otros sistemas biológicos.

  - Histopatología e inmunohistoquímica de tejido.

- En caso de pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue en situación no epidémicas de dengue, no confirman ni descartan el caso probable de dengue. Asimismo, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  - Su uso solo se contempla para establecimientos de salud de difícil acceso a un laboratorio que no cuenten con transferencia tecnológica o laboratorio de referencia regional.

  - Aquellos casos con resultado positivo a pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue que cumplan con la definición de caso ingresan al aplicativo NOTI del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica e Inteligencia Sanitaria como casos probables y se obtienen muestras de suero para confirmar los resultados con otras pruebas citadas.

  - Aquellos casos con resultado positivo o negativo a las pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue y que cumplan con la definición de caso probable para dengue deben ser “manejados clínicamente como dengue” y se obtiene una muestra de suero para corroborar el resultado de la prueba inmunocromatográfica para apoyar el diagnóstico y realizar la reclasificación epidemiológica del caso.

- En caso de las pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue en situación de epidemia de dengue, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  - Las pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue usadas en la Unidad de Vigilancia Clínica de Dengue de los establecimientos de salud con resultado positivo a esta prueba son consideradas como apoyo diagnostico si el paciente cumple con el criterio clínico epidemiológico de la definición de caso probable para dengue.

  - Frente a un resultado negativo a pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue, se toma una muestra de suero para corroborar los resultados con otras pruebas.

  - Aquellos casos con resultado positivo o negativo a las pruebas inmunocromatográficas para marcadores del antígeno NS1 o anticuerpo IgM para dengue y que cumplan con la definición de caso probable para dengue deben ser “manejados clínicamente como dengue”; y, en los casos con signos de alarma, formas graves, hospitalizados por dengue y grupos de riesgo, como gestantes, neonatos, niños, adultos mayores, pacientes con comorbilidad, se les debe tomar una muestra biológica (suero)

b) Confirmación par nexo epidemiológico para dengue: Esta definición se aplica solo en situación de brote o epidemia donde se ha comprobado la circulación del virus del dengue y no se confirme circulación simultanea de otras arbovirus en la misma temporalidad y espacio.

Se considera confirmación por nexo epidemiológico a todo caso probable que cumple con la definición de caso para dengue (criterio epidemiológico más criterio clínico) y que, dentro de los 200 metros a la redonda de su lugar probable de infección o residencia, se identifique casos confirmados por laboratorio con fecha de inicio de síntomas dentro de las 2 semanas previas al inicio de síntomas del caso probable a clasificar.

No entran a nexo epidemiológico los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave, los mismos que deben contar con la ficha de investigación clínico epidemiológica para la vigilancia de dengue, chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis y con una muestra de suero para diagnóstico de dengue.

- **Caso descartado de dengue:** Persona que fue considerada como probable a dengue y que cumple con alguno de los siguientes criterios:

  - Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y un resultado negativo de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad por una de las siguientes pruebas de diagnóstico:

    - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
    - Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.
    - En caso de ELISA IgM para dengue en una sola muestra con tiempo de enfermedad mayor igual a 14 días desde el inicio de síntomas.

  - No evidencia de seroconversión en ELISA IgM para dengue en muestras pareadas. Para una mejor identificación de anticuerpos, la segunda muestra debe ser tomada a los 14 días desde el inicio de síntomas y, como máxima, hasta los 30 días desde el inicio de síntomas.

  - Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable para dengue (criterio clínico y criterio epidemiológico).

  - Identificación por laboratorio de otro agente causal y que no cumpla con definición de caso probable para dengue.

  - Caso notificado sin examen de laboratorio sin nexo epidemiológico o cuya investigación clínico-epidemiológica sea compatible con otra patología.

  - En caso de resultados negativos a ELISA antígeno NS1 o ELISA IgM para dengue menor a 14 días, para descartar un caso, se debe considerar:

- En zonas no endémicas, paciente con resultado negativo par laboratorio, de acuerdo al tiempo de enfermedad para la obtención de muestra y que no existan casos confirmados en el entorno que frecuenta el paciente.

- En zonas endémicas durante el periodo de transmisión no epidémico paciente con resultado negativo por laboratorio, de acuerdo al tiempo de enfermedad para la obtención de muestra y que cumplan con alguno de los siguientes criterios: i) No existan casos confirmados en el entorno que frecuenta el paciente; o, ii) presente un cuadro clínico compatible a otra etiología.

Fuente: *NTS N°230-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2025_14_100517.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_arbovirosis.pdf

Enfermedad de carrión

- **Caso probable de la Enfermedad de Carrión Aguda (ECA):** Toda persona que reside o precede de un área endémica y que presenta sensación febril o fiebre en los últimos 14 días, acompañado de uno o más de las siguientes manifestaciones clínicas:

  - Cefalea.
  - Mialgia (dolor muscular).
  - Artralgias (dolor de articulaciones).
  - Palidez (poco frecuente y tardío).
  - Anemia (poco frecuente y tardío).

- **Caso probable de la enfermedad de Carrión grave:** Es un caso probable de la ECA que presenta uno o más de las siguientes manifestaciones clínicas:

  - Taquicardia.
  - Taquipnea.
  - Anemia severa.
  - Conciencia alterada.
  - Purpura coagulopatía.
  - Pericarditis.
  - Anasarca.
  - Insuficiencia cardiaca.
  - Deterioro clínico a pesar de recibir tratamiento.
  - Trastorno neurológico.
  - Edema agudo pulmonar.
  - Disfunción orgánica o multiorgánica.
  - Distensión abdominal.
  - Hemorragia digestiva.

- **Caso probable de Enfermedad de Carrión Eruptiva (ECE): T**oda persona que reside o precede de un área endémica y que presenta una o más lesiones en la piel, que pueden ser verrucosas o nodulares y con tiempo de evolución no mayor a 6 meses. Las verrucosas son de coloración rojiza, fácilmente sangrante y de superficie lisa. Las nodulares son lesiones subdérmicas, poco consistentes, móviles y no dolorosas.

- **Caso confirmado de enfermedad de carrión aguda y eruptiva:** Todo caso probable de ECA y ECE se confirma si el resultado es positivo a una o más de las siguientes pruebas de laboratorio:

  - Frotis sanguíneo.

  - Test de Elisa: Elisa IgM e IgG reactivos o seroconversión de Elisa IgG negativo a positivo.

  - RT-PCR o PCR positivo en cepas aisladas de hemocultivos, muestras de sangre total o cualquier liquido o tejido biológico.

  Nota: Se deben realizar todas las pruebas para mejorar la sensibilidad del diagnóstico. En el caso de frotis se extrae, como mínimo, 2 frótices para mejorar la sensibilidad. En casos graves u hospitalizados y si el médico tratante lo requiere, se puede realizar el diagnóstico de laboratorio de coinfecciones como leptospirosis, rickettsiosis o alguna otra enfermedad endémica de la zona de residencia o procedencia.

- **Caso descartado de enfermedad de carrión aguda o eruptiva**

  a) **Por laboratorio:** Todo caso probable de ECA o ECE que tenga resultado negativo a todas las pruebas, se descarta.

  - Frotis sanguíneo: Frotis negativo.

  - Test de Elisa, de acuerdo a los siguientes resultados:

    - IgM e IgG no reactivo, se descarta el caso.

    - IgM reactivo-IgG no reactivo, en una primera muestra, requiere evaluación de segunda muestra obtenida después de 10-15 días de la primera muestra, si el resultado de IgG continua no reactivo, se descarta el caso.

    - RT-PCR o PCR negativo en cepas aisladas de hemocultivos, muestras de sangre total o cualquier liquido o tejido biológico.

  b) **Por evidencia de otra enfermedad en situación de brote:** En situación de brote, el caso probable de enfermedad de Carrión es descartado cuando tiene un diagnóstico confirmado a otra enfermedad, sin considerar las coinfecciones frecuentes.

- **Caso fallecido por enfermedad de carrión:** Cuando cumple con las pruebas de laboratorio que confirma el caso, el diagnóstico clínico de enfermedad de Carrión grave y antecedente epidemiológico.

- **Caso descartado de fallecido por sospecha de la enfermedad de Carrión**

  a) Cuando el case fallecido no cumple con los criterios de confirmación de la enfermedad de Carrión.

  b) Cuando la causa básica del fallecimiento está en duda, se debe consultar con el especialista en enfermedades infecciosas o profesionales con experiencia en manejo de cases graves de la enfermedad de Carrión.

Fuente: *NTS N° 231-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Carrión" https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/documentos-normativos/documentos-normativos_20258_22_160710.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/03/ENFERMEDAD-DE-CARRION-Ficha-de-investigacion-clinico-epidemiologica-de-enfermedad-de-Carrion.pdf

Enfermedad de chagas

- **Caso probable de chagas agudo:** Caso con fiebre como síntoma principal, sin otra explicación y tenga al menos uno o más de los siguientes signos o síntomas:

  - Adenomegalia,
  - Hepatomegalia,
  - Esplenomegalia,
  - Chagoma (inflamación en el sitio de la infección hasta 8 semanas de duración.
  - Exantema,
  - Malestar general,
  - Meningoencefalitis,
  - Signo de Romaña,
  - Chagoma hematógeno (tumoración plana única o múltiple),
  - Miocardiopatía,
  - Miocarditis o
  - Lesiones en la piel.

  Además, uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos:

  - Procede o vive en área con infestación por triatominos,
  - Caso sin chagoma de inoculación o signo de Romaña con antecedente de haber recibido sangre o hemoderivados en los últimos 2 meses de un donante infectado por *Trypanosoma cruzi*, confirmado por dos exámenes serológicos diferentes en cualquiera de las situaciones siguientes:

    - Segundo examen de la muestra original (muestra usada para el tamizaje).
    - Nueva muestra del donante, obtenida durante la investigación o tenga
    - Antecedente de diagnóstico de enfermedad de chagas.

  - Antecedente de haber sido trasplantado en los últimos 3 meses de un donante infectado por *T. cruzi* confirmado por laboratorio como en el caso de la transmisión transfusional.

- Compromiso inmunológico (paciente con sida, tratamiento con corticoides, etc).

- **Caso confirmado de chagas agudo:** Es un caso probable de chagas agudo, confirmado por:

  - Hallazgo del parásito por examen directo de sangre fresca, frotis, gota gruesa, hemocultivo o microhematocrito).

  - Técnicas moleculares (Reacción en cadena de la polimerasa).

- **Caso probable de chagas congénita:** Menor hasta 1 año de edad, hijo de madre seropositiva (reactiva a dos pruebas serológicas diferente contra anticuerpos específicos de *Trypanosoma cruzi*).

- **Caso confirmado de chagas congénita:** Caso probable de enfermedad de chagas congénita sin antecedentes de exposición al vector, transfusión sanguínea o trasplante de órgano con:

  - Demostración de Trypanosoma cruzi por exámenes parasitológicos o

  - Presencia de anticuerpos específicos de origen no materno (IgM) detectados a los 9 y 12meses después del nacimiento.

- **Caso probable de chagas crónico:** Caso reactivo a una prueba de tamizaje con o sin signos o síntomas compatibles con enfermedad de chagas en etapa crónica.

- **Caso confirmado de chagas crónico:** Es un caso probable de chagas crónico, confirmado por alguna de las siguientes pruebas:

  - Dos pruebas confirmatorias de principios diferentes.

  - Xenodiagnóstico o

  - PCR.

Esta definición es únicamente para vigilar los donantes y las gestantes.

Fuente: *Protocolos de vigilancia epidemiológica Parte I. Serie normas de vigilancia epidemiológica en salud pública. Oficina General de Epidemiología – Ministerio de Salud 2006. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/07/Protocolo_Chagas.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/f_chagas.pdf

Leishmaniasis

- **Caso probable de Leishmaniasis Cutánea (LC):** Todo paciente procedente o residente de áreas endémicas o una nueva área de transmisión de leishmaniasis, que presenta el siguiente criterio: Una o más úlceras cutáneas, superficiales de bordes bien definidos, elevados, indurados y de base eritematosa con un tiempo de aparición igual o mayor a 2 semanas de la evolución.

- **Caso confirmado de Leishmaniasis Cutánea (LC):** Todo caso probable de LC con resultado positivo a uno o más de los siguientes métodos:

  - Parasitológicos:

    - Frotis*

    - Cultivo

  - Inmuno-serológico:**

    - Inmunofluorescencia indirecta (IFI), título > a 1/40

  - Molecular***

    - Detección molecular de ADN por PCR.

    * Método de primera elección

    ** En casos donde el paciente cuente con un tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 3 meses.

    *** En casos donde de manera repetida resulte negativo en el examen microscópico directo.

- **Caso descartado de Leishmaniasis Cutánea (LC):** Todo caso probable de LC con resultado negativo a los siguientes métodos: Inmuno-serológicos IFI e intradermorreacción (IDRM), y detección molecular de ADN o con resultado positivo a otras patologías.

- **Caso probable de Leishmaniasis Mucocutánea (LMC): T**odo paciente procedente de un área endémica, con antecedente de exposición y con una o más lesiones granulomatosas elevadas en el tabique, laringe, faringe o tráquea con o sin antecedentes de infección de LC, la cual aparece a los meses o años después de haber cicatrizado la lesión.

- **Caso confirmado de Leishmaniasis Mucocutánea (LMC):** Todo caso probable de LMC con resultado positivo a los métodos descritos en el flujograma de notificación de LMC:

  - Intradermorreacción (IDRM) más,

  - Inmunofluorescencia (IFI) con título > a 1/40.

- Molecular*

- Detección molecular de ADN por PCR.

* En casos donde los métodos anteriores resulten negativos y persista la sospecha de la enfermedad.

- **Caso descartado de Leishmaniasis Mucocutánea (LMC):** Todo caso probable de LMC con resultado negativo a: IDRM, IFI y detección molecular de ADN o resultado positivo a otras patologías.

- **Caso humano sospechoso de Leishmaniasis Visceral (LV):** Todo paciente procedente o residente de área endémica de LV que presenta fiebre mayor a 10 días, signos de hepatomegalia y/o esplenomegalia.

- **Caso humano confirmado de Leishmaniasis Visceral (LV):** Todo caso sospechoso de LV que ha sido confirmado por el INS o por laboratorios de referencia regionales implementados en el marco de la transferencia tecnológica de acuerdo al flujograma de notificación de LV, por uno de los siguientes métodos:

  - Prueba rápida inmunocromatográfica específica rK 39 para *Leishmania (Leishmania) infantum* o *Leishmania infantum chagasi*.

  - Frotis con tinción Giemsa o May-Grunwald–Giemsa muestra de aspirado de médula ósea.

  - Cultivo “in vitro” en medio agar sangre, con identificación de promastigotes en NNN (Novy, Nicolle y McNeal), Seneckjie, por punción lumbar de médula ósea.

  - Prueba de Inmunofluorescencia indirecta con título > a 1/80 con antígenos específicos para L*eishmania (Leishmania) infantum* o *Leishmania infantum chagasi*.

  - Por detección molecular de ADN de Leishmania (Leishmania) infantum o Leishmania infantum chagasi.

  Nota: *Leishmania (Leishmania) infantum* o *Leishmania infantum chagasi*, agente etiológico de leishmaniasis visceral en América sinónimo *Leishmania chagasi*, agente etiológico de leishmaniasis visceral en Asia, África y Europa.

- **Caso humano descartado de Leishmaniasis Visceral (LV):** Todo caso sospechoso de LV con resultado negativo a uno de los siguientes métodos: parasitológicos, inmuno-serológicos o moleculares o por evidencia de otra enfermedad o por otra especie de *Leishmania (Leishmania) infantum* o *Leishmania infantum chagasi*.

Fuente: *NTS N°225-MINSA/CDC-2025 “Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Leishmaniasis en el Perú”. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/LEISHMANIASIS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/05/LEISHMANIASIS-ficha-clinico.pdf

Malaria

- **Caso sospechoso:** De acuerdo al tipo de área se divide en:

  - **Endémicas:** Se trata de la persona que presenta fiebre o refiera historia de fiebre en los últimos 15 días y vive en área endémica de malaria o en focos. Además, presenta al menos uno de los siguientes síntomas o signos: Escalofríos (temblor), cefalea (dolor de cabeza), malestar general, palidez marcada (excepcionalmente en niños y gestantes).

    Nota: En zonas endémicas de malaria pueden presentarse casos que, al examen de gota gruesa o frotis durante la vigilancia proactiva o reactiva, tengan resultados positivos, sin que manifiesten ningún síntoma.

  - **No endémicas:** Se trata de la persona que presenta fiebre o refiere historia de fiebre en los últimos 15 días; además, cumple una de las siguientes especificaciones:

    - Presente antecedente de haber viajado en el último mes a una zona endémica.
    - Proceda de un área endémica o foco activo.
    - Tenga el antecedente de haber tenido malaria en los últimos 3 años.

    Nota: Personal de la salud capacitado debe tomar una muestra para realizar el examen de gota gruesa o frotis y la PDR para descartar la infección por *Plasmodium*.

- **Caso confirmado de malaria:** Es el caso sospechoso confirmado por laboratorio (examen de gota gruesa, frotis, PDR o Prueba molecular de la Reacción de la Cadena de la Polimerasa (PCR), con hallazgo de alguna(s) de la(s) siguiente(s) especie(s): *Plasmodium vivax*, *P. falciparum, P. malariae, P. ovale* o *P. knowlesi* y sin criterios de gravedad. Estos casos confirmados de malaria se utilizan con fines de vigilancia epidemiológica de malaria en el país.

- **Caso confirmado de malaria grave:** Se trata del caso confirmado de malaria que presenta parasitemia por formas asexuadas de *falciparum, P. vivax* o *P. knowlesi,* y al menos uno de los siguientes criterios de gravedad:

  - Escala de Glasgow < 11 en adultos o escala de Blantyre <3 en niños.
  - Postración: Debilidad generalizada; la persona no puede sentarse, pararse o caminar sin ayuda.
  - Convulsiones múltiples: Más de 2 convulsiones por día (24 horas).
  - Acidosis: Un déficit de base > 8 mEq/L; o, si no existiera este dato, considerar bicarbonato de plasma < 15 mM o lactato plasmático venoso
    > 5 mM.

Nota: La acidosis severa se manifiesta clínicamente como dificultad respiratoria (respiración rápida, profunda y dificultosa).

- Hipoglicemia: Glucosa en sangre o plasma (<40 mg/dL).
- Anemia severa: Concentración de hemoglobina ≤ 5g/dl o un valor de hematocrito ≤15% en niños < de 12 años de edad (< 7g/dL) y < 20% en adultos con un conteo > 1000/µL.
- Insuficiencia renal aguda: Plasma o creatinina > 3 mg/dL o urea > 20 mmol/µL.
- Ictericia (piel amarillenta): Plasma o bilirrubina > 3 mg/dL con un conteo > 100 000 /µL por *falciparum* y > 20 000/L por *P. knowlesi*.
- Edema pulmonar: Radiológicamente confirmado o saturación de oxígeno < 92 % en el aire con una tasa respiratoria > 30/min, a veces con tiraje en el pecho y crepitaciones a la auscultación.
- Sangrado masivo: Incluye sangrado prolongado o recurrente de la nariz, encías o sitios de venopunción; hematemesis (vómito con sangre) o melena (heces oscuras y de olor fétido).
- Shock: El shock compensado es definido como relleno capilar ≥ 3 segundos o temperatura gradiente en la pierna (extremidad media a proximal), pero no hipotensión. El shock descompensado es definido como la presión sanguínea sistólica ≤70 mm Hg en niños y ≤ 80 mm Hg en adultos, con evidencia de perfusión deteriorada (periferias frías o reposición capilar prolongada).
- Hiperparasitemia (Parasitemia elevada):
  - Parasitemia por *falciparum* > 10% (>10 000 parásitos /µL).
  - Parasitemia por *knowlesi* >100 000/µL; y,
  - No hay umbrales de parasitemia para *vivax*.

Esta definición de caso confirmados de malaria grave se utiliza con fines de vigilancia epidemiológica de malaria en el país.

Nota: El personal de la salud debe descartar otras causas que expliquen el cuadro clínico de la enfermedad antes de clasificar el caso.

- **Caso descartado de malaria:** Se trata del caso sospechoso de malaria con resultado negative a alguna de las siguientes pruebas: Gota gruesa o frotis o PDR.
- **Caso inducido:** Es el caso de malaria que puede atribuirse a una transfusión de sangre u otra forma de inoculación parenteral del parasito, pero no debido a la transmisión por mosquitos.
- **Caso introducido:** Es el caso de malaria autóctono con pruebas epidemiológicas sólidas que lo vinculan directamente con un caso importado conocido (primera generación de transmisión

local a partir de un caso importado).

- **Caso de recaída:** Se refiere al caso de malaria que tiene como antecedente haber tenido una infección por P. vivax o P. ovale en los últimos 3 años, sin ningún caso epidemiológicamente vinculado en los alrededores o antecedente de viaje a una zona endémica. La latencia (en fase de hipnozoitos) de una recaída puede ser de 6 a 12 meses. La detección de recaídas no es signo de fracaso operative, pero cuando ocurre se debe evaluar la posibilidad de que persista la transmisión.

- **Muerte por malaria:** Se refiere a la muerte de un paciente con criterio clínico epidemiológico de malaria grave en quien se demuestra la presencia del parasito por gota gruesa o frotis o PDR o PCR.

Fuente: N*TS N°228-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en el contexto de la Eliminación de la Malaria en el Perú. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/05/MALARIA_NTS-N%C2%B0228-MINSA-CDC-2025-.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/04/Ficha-de-investigacion-epidemiologica-de-malaria-_16042026-UTEMOTV.pdf

Mayaro

- **Caso probable de mayaro:** Se refiere a la persona que presenta fiebre y artralgia que no es explicada clínicamente por otra condición médica y con un tiempo de enfermedad menor o igual a 7 días de evolución y que reside o ha visitado áreas boscosas o zonas con transmisión conocida para Mayaro, en los últimos 14 días y presenta 2 o más de las siguientes manifestaciones:

  - Cefalea.
  - Mialgias.
  - Edema articular localizado.
  - Exantema o rash (aproximadamente a partir del segundo a tercer día).

- **Caso confirmado de mayaro:** Se denomina así a la persona que es considerada como probable a mayaro y que tenga al menos una de las siguientes pruebas confirmatorias por laboratorio:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
  - Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.
  - Detección de anticuerpos de ELISA IgM para mayaro en aquellos casos que cumplan con la definición de caso en zonas endémicas y/o este dentro de un contexto de brote de mayaro.
  - Evidencia de seroconversión en ELISA IgM en muestras pareadas en zonas donde no hay transmisión de mayaro. Para una mejor identificación de anticuerpos, la segunda muestra debe ser tomada a los 14 días del inicio de síntomas y, como máximo, hasta 30 días después del inicio de síntomas.
  - Histopatología e inmunohistoquímica de tejido.
  - Confirmación por nexo epidemiológico, solo en situación de brote o epidemia donde se ha comprobado la circulación del virus de mayaro y no se confirme brotes por otros arbovirus en la misma temporalidad y espacio.

- **Caso descartado de mayaro:** Se denomina así a la persona que es considerada como probable a mayaro y que cumple alguno de los siguientes criterios:

  - Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y resultados negativos de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad y que tenga al menos una de las siguientes pruebas de diagnóstico en:

- Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
- Asilamiento viral u otros sistemas biológicos.
- En caso de ELISA IgM para mayaro en muestras mayor igual a 5 días de tiempo de enfermedad.
- Evidencia de seroconversión en ELISA IgM para mayaro en muestras pareadas.

- Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable para mayaro.
- Identificación por laboratorio de otro agente causal.

Fuente: *NTS N°230-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2025_14_100517.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_arbovirosis.pdf

Oropouche

- **Caso probable de oropouche:** Se refiere a toda persona con fiebre y cefalea intensa con un tiempo de enfermedad menor o igual a 7 días de evolución, que reside o ha visitado en los últimos 14 días áreas de transmisión o con antecedente de brote de oropouche y presenta uno o más de los siguientes signos y síntomas:

  - Fotofobia.
  - Mialgias. Artralgias.
  - Lumbalgia.
  - Nauseas o vómitos

  En estadios más graves de la enfermedad de oropouche pueden presentarse signos y síntomas neurológicos (diplopía, vértigo, ataxia, parestesia, meningitis, encefalitis, meningoencefalitis); así también las gestantes pueden presentar muerte fetal y abortos.

  La cefalea intensa suele tener una localización posterior (parietooccipital), con puntaje de 7 en la escala del dolor del 1 al 10.

- **Caso confirmado de oropouche:** Se refiere a toda persona considerada como probable a oropouche y que tenga al menos una de las siguientes pruebas confirmatorias por laboratorio:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
  - Aislamiento viral en cultivo celular u otros sistemas biológicos.
  - ELISA IgM para oropouche en aquellos casos que cumplan con la definición de case, en zonas endémicas o este dentro de un contexto de brote de oropouche.
  - Evidencia de seroconversión en ELISA IgM en muestras pareadas en zonas donde no hay transmisión de oropouche. Para una mejor identificación de anticuerpos, la segunda muestra debe ser tomada a los 14 días desde el inicio de síntomas y, como máximo, hasta 30 días después del inicio de síntomas.
  - Histopatología e inmunohistoquímica de tejido.
  - Confirmación par nexo epidemiológico, solo en situación de brote o epidemia donde se ha comprobado la circulación del virus de Oropouche y no se confirme circulación simultanea de otras arbovirus en la misma temporalidad y espacio.

- **Caso descartado de oropouche:** Se denomina así a la persona que es considerada como probable a oropouche y que cumple alguno de los siguientes criterios:

  - Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y resultados negativos de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad por una de las siguientes pruebas de diagnóstico:

- Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
- Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.
- En caso de ELISA IgM para oropouche en muestras mayor igual a 5 días de tiempo de enfermedad.
- Evidencia de seroconversión en ELISA IgM para oropouche en muestras pareadas.

- Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable de oropouche.
- Identificación por laboratorio de otro agente causal.

Fuente: *NTS N°230-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2025_14_100517.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_arbovirosis.pdf

Zika

Definición de zika en población general

- **Caso probable de zika:** Persona con exantema maculopapular y prurito desde el inicio de la enfermedad y con un tiempo de enfermedad menor o igual a 7 días de evolución, que resida o tenga antecedentes de viaje a áreas con transmisión de Zika o con infestación del vector Aedes aegypti, dentro de los 14 días antes del inicio de los síntomas y que presenta 2 ó 6 más de las siguientes manifestaciones:

  - Conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival.
  - Artralgia.
  - Mialgia.
  - Edema periarticular.
  - Temperatura de 38 a 38,5°C.

- **Caso confirmado de zika:** Persona que es considerada como probable a Zika o asintomático de Zika y que tenga al menos una de las siguientes pruebas positivas de laboratorio para Zika:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
  - Aislamiento viral par cultivo celular u otros sistemas biológicos.

- **Caso confirmado de zika par transmisión sexual (zonas sin vector):** Persona con una muestra positiva a zika por laboratorio que no tenga residencia o antecedentes de viaje a áreas con transmisión de zika y con antecedente de contacto sexual sin protección en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas, con una persona que en las 8 semanas previas al contacto sexual tenga antecedente de residencia o viaje a un área con transmisión confirmada de zika y tenga una prueba positiva a zika. Si no hay confirmación de la muestra positiva de la pareja no se considera caso confirmado por esta vía de transmisión.

- **Caso descartado de zika:** Persona que fue considerada como probable a zika y que cumple con alguno de los siguientes criterios:

  - Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y resultados negativos de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad par:
    - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).
    - Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.

- Identificación por laboratorio de otro agente causal o de otro diagnóstico médico exantemático o reumatológico.

- Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable.

Gestante con zika

- **Caso probable de zika en gestantes:** Gestante que cumple con uno de los siguientes criterios:

  - Toda gestante que cumple con la definición de caso probable a zika.

  - Gestante que no resida o no haya visitado áreas epidémicas o endémicas de zika y con antecedente de contacto sexual sin protección dentro de los ultimas 14 días antes del inicio de los síntomas, con una persona que en las 8 semanas previas al contacto sexual tenga antecedente de residencia o viaje a un área con transmisión de virus zika confirmada y que tenga prueba positiva a zika.

  - Gestante cuyo feto presenta hallazgos ecográficos (ultrasonografía) de microcefalia fetal, calcificaciones intracraneales, ventriculomegalia o alteraciones asociadas a infección por el virus zika y que cumpla con uno los siguientes criterios:

    - Residente o que haya visitado áreas con trasmisión de virus zika confirmada durante la gestación.

    - Con antecedente de contacto sexual sin protección con una persona que en las 8 semanas previas al contacto sexual tenga antecedentes de residencia o viaje a un área en brote de Zika confirmado y tenga prueba positiva a Zika.

- **Caso confirmado de zika en gestantes:** Gestante considerada como probable a zika o gestante asintomática y que tenga al menos una de las siguientes pruebas positivas de laboratorio para zika en:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).

  - Aislamiento viral por cultivo celular u otros sistemas biológicos.

- **Caso descartado de zika en gestantes:** Gestante que es considerada como gestante probable a Zika y que cumple alguno de los siguientes criterios:

  - Tener una evaluación del criterio epidemiológico, clínico y resultados negativos de laboratorio de acuerdo al tiempo de enfermedad por las siguientes pruebas de diagnóstico:

    - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).

    - Aislamiento viral u otros sistemas biológicos.

- Identificación par laboratorio de otro agente causal u otro diagnóstico médico exantemático o reumatológico.

- Paciente notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable en gestantes con zika.

Infección congénita relacionada a zika

- **Caso probable de zika en gestantes:** Gestante que cumple con uno de los siguientes criterios:

- **Probable infección congénita relacionada a zika: S**e considera si cumple con una de las siguientes definiciones:

  - **Recién nacido expuesto zika sin síndrome congénito:** Recién nacido aparentemente sano, cuya madre, durante su periodo de gestación, fue captada como caso probable o confirmado a virus zika.

  - **Síndrome congénito con asociación probable a zika:** Recién nacido vivo o con muerte neonatal, u óbito fetal, cuya madre tenga antecedentes de haber sido captada como caso confirmado o probable a zika durante el primer y segundo trimestre de gestación y que el producto presente alguna de las siguientes manifestaciones:

    - Microcefalia: Recién nacido u óbito fetal con medida de circunferencia occipito frontal (perímetro cefálico), a las 24 horas después de nacer, por debajo del percentil 3 en neonatos a término de 37 a 39 semanas y en prematuros menores de 37 semanas de edad gestacional, según las tablas de “Fenton para niños y niñas” y, a partir de las 40 semanas de gestación en las tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños y niñas con medida de perímetro cefálico por debajo de -2 desviaciones estándares (SD, por sus siglas en inglés).

    - Malformación congénita del sistema nervioso central (SNC) detectada por cualquier estudio de imágenes o manifestaciones clínicas de compromiso neurológico (ver Anexo 5 de la NTS N°-MINSA/CDC-2025).

    - Otra malformación congénita asociada a infección par el virus Zika fuera del SNC (ver Anexo 5 de la NTS N°-MINSA/CDC-2025).

- **Confirmación de infección congénita relacionada a zika:** Recién nacido expuesto a zika sin síndrome congénito o recién nacido con síndrome congénito con asociación probable a zika que tenga al menos una de las siguientes pruebas de laboratorio positivas:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real) en suero u orina.

  - Prueba molecular en tejido materno fetal.
  - Histopatología e inmunohistoquímica de tejido materno fetal.

- ELISA IgM.

- **Descarte de infección congénita relacionada a zika:** Recién nacido u óbito fetal que cumple con alguno de los siguientes criterios:

  - Recién nacido expuesto a zika sin síndrome congénito con resultado negativo a prueba molecular o ELISA IgM negativo en la primera muestra.

  - Síndrome congénito probable a zika con resultado de laboratorio de prueba molecular negativa llevado a cabo en la primera muestra.

  - Síndrome congénito probable a zika sin evidencia de seroconversión en ambas muestras de suero, la segunda muestra tomada a los 7 días desde la primera muestra.

  - Síndrome congénito probable a zika con identificación de otro agente infeccioso, como Toxoplasmosis, sífilis, rubeola, Citomegalovirus y Herpes (TORCH), y no se ha tenido prueba positiva para zika.

  - Resultado negativo a prueba molecular o ELISA IgM en una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR).

  - Recién nacido u óbito fetal con otras anormalidades congénitas relacionadas a enfermedades hereditarias o no contempladas en el Anexo 5 de la NTS N°-MINSA/CDC-2025.

  - Caso notificado que no cumpla con los criterios de la definición de caso probable de infección congénita relaciona a zika.

Síndrome de Guillain Barré asociado a zika

- **Caso de SGB con asociación probable a zika:** Persona que cumple con uno de los siguientes criterios:

  - Caso de SGB que reside o ha visitado áreas con transmisión activa de zika en los 30 días previos al inicio del cuadro clínico de SGB.

  - Caso de SGB que haya tenido contacto sexual sin protección con una persona con residencia o antecedente de viaje en las últimas 8 semanas a un área de transmisión activa de zika o tenga una prueba positiva para zika.

- **Caso de SGB con asociación confirmada a zika:** Persona considerada como SGB y que tenga al menos un resultado laboratorial positivo de infección reciente para zika en:

  - Prueba molecular (RT-PCR en tiempo real).

  - ELISA IgM positive en suero o LCR, sin resultado positivo a otra etiología.
  - Aislamiento viral por cultivo celular u otros sistemas biológicos.

- **Caso de SGB con asociación descartada a zika:** Persona que presenta uno de los siguientes criterios:

  - Caso de SGB con resultado laboratorial negativo a prueba molecular o de ELISA IgM a la enfermedad del virus zika.

  - Caso que no cumpla con la definición de caso de SGB con asociación probable a zika.

  - Caso que no cumpla con la definición de caso de SGB.

  - Caso de SGB con identificación de otro agente infeccioso, como Campylobacter jejuni, CMV, Enterovirus, virus Epstein Bar (VEB), VIH, dengue, chikungunya, SARS CoV-2 u otros agentes bacterianos y virales, y no se cuenta con resultado positivo a zika.

Fuente: *NTS N°230-MINSA/CDC-2025 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras arbovirosis en el Perú". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2025_14_100517.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_arbovirosis.pdf

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/f_inf_cong_zika.pdf

Vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas

Carbunco (ántrax)

En humanos:

- **Caso probable:** Caso que es compatible con la descripción clínica (cutáneo, gastrointestinal, respiratorio, meníngeo), procedente de zona enzoótica y/o que tiene un enlace epidemiológico con casos confirmados o sospechosos de animales o productos de origen animal, y al menos comprobación de *B. anthracis* mediante el examen microscópico de frotis teñidos de líquido vesicular, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural y heces del paciente.

- **Caso confirmado:** Caso probable que es confirmado por la presencia de *Bacillus anthracis* mediante aislamiento, serología o pruebas moleculares.

- **Contacto:** Persona, sin cuadro clínico, que ha participado en el faenamiento, o ha manipulado carne, productos o subproductos contaminados; así como toda persona que ha consumido carne o vísceras de ganado muerto por carbunco. El contacto deberá tener seguimiento por siete días, considerando el rango máximo del periodo de incubación.

Formas clínicas para aplicar las definiciones de caso de carbunco en humanos:

- **Carbunco cutáneo:** Todo caso que presenta lesión cutánea que en el curso de 1 a 6 días evoluciona de una etapa papular a una vesicular y finalmente se convierte en una escara negra deprimida, acompañada de edema leve o extenso, con antecedente de contacto directo con animales infectados (vivos, muertos o con sus productos).

- **Carbunco gastrointestinal: T**odo caso que presente náuseas, vómitos y anorexia, seguidos de fiebre, luego de ingesta de carne contaminada procedente de animales infectados.

- **Carbunco respiratorio:** Todo caso que luego de un pródromo breve, similar al de una infección respiratoria viral aguda, evoluciona rápidamente presentando hipoxia, disnea y temperatura alta, con examen radiográfico de ensanchamiento mediastinal y antecedente de contacto con caso confirmado o sospechoso en animales o con productos de origen animal contaminados.

En animales:

- **Caso de carbunco animal:** Infección aguda que afecta a los bovinos, ovinos, porcinos y otros animales herbívoros, se caracteriza por la presentación de fiebre, depresión, dificultad respiratoria y convulsiones, es común la presentación de sangrado por los orificios naturales del cuerpo del animal.

- **Caso animal probable:** Animal que presenta síntomas clínicos de la enfermedad y con nexo epidemiológico de procedencia de área endémica o contacto con animal confirmado.

- **Caso animal confirmado:** Caso probable que es confirmado por la presencia de Bacillus anthracis mediante aislamiento, serología o pruebas moleculares.

Fuente: *DS N°065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-PARA-LA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-DE-LAS-ENFERMEDADES-ZOONOTICAS-ACCIDENTES-POR-ANIMALES-PONZONOSOS-Y-EPIZOOTIAS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/Ficha-Clinico-Epidemiologica-de-caso-de-Antrax-Carbunco.pdf

Fasciolosis humana

- **Caso sospechoso:** Toda persona que cumple con la descripción clínica y el antecedente epidemiológico de fascioliasis.
- **Caso probable:** Se considera a:
  - Todo caso sospechoso que presenta eosinofilia con cifras que pueden llegar hasta el 90%; o,
  - transaminasas hepáticas elevadas; o,
  - Exámenes compatibles con disfunción biliar o cálculos biliares a través ecografía abdominal superior o colangiografía.
- **Caso confirmado:** Todo caso probable o persona con prueba de tamizaje en quien se detecta:
  - Huevos del parásito en examen de muestras de heces (Kato Kat o técnica de sedimentación rápida (TSR); o,
  - Presencia de anticuerpos específicos IgG en suero a los antígenos de fasciola hepática (IgG 4 del INS o FAS-2). Western blot; o,
  - Hallazgo de formas adultas con técnicas no invasivas o quirúrgicas.

Fuente: *NTS N°148-MINSA/DIGIESP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Fasciolosis Humana en el Perú". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/NTS_FASCIOLOSIS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/Ficha-clinica-epidemiologica-de-FACIOLOSIS-humana.pdf

Leptospirosis

- **Caso probable:** Paciente con cuadro febril agudo (≥ 38 °C, de inicio brusco, menor o igual a 7 días), que presente los siguientes síntomas: cefalea de diversa intensidad, mialgias de moderada a intensa a predominio de pantorrillas y espalda, que puede estar acompañado de otras manifestaciones clínicas: respiratorias, neurológicas, gastrointestinales u oftalmológicas; y,
  Con antecedentes de exposición a potenciales fuentes de infección durante últimos 30 días:

  - Contacto con fuentes de agua, suelo o superficies potencialmente contaminadas con orina de animales (roedores, animales domésticos y/o silvestres), incluyendo actividades recreativas o de riesgo ocupacional; o,

  - Que resida o con antecedentes de viajes a zonas con reporte de casos o zonas afectadas por lluvias y/o inundaciones; y

Con o sin las siguientes pruebas de laboratorio:

  - Prueba de ELISA IgM reactiva o indeterminada para detección de anticuerpos contra leptospira; o,

  - Pruebas de microaglutinación (MAT) con títulos inferiores a 1:800.

- **Caso confirmado:** Caso probable con los siguientes resultados de laboratorio:

  - Detección del ADN de leptospira por la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a partir de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo (LCR) o tejidos; o,

  - Detección de anticuerpos mediante la prueba de microaglutinación (MAT) con títulos iguales o superiores a 1:800 en una sola muestra; o,

  - Seroconversión en dos muestras pareadas de suero mediante la prueba MAT, con variación de 4 o más veces el título de anticuerpos. La segunda muestra deberá ser obtenida entre los 14 y 30 días de la primera; o,

  - Aislamiento de la bacteria mediante cultivo, a partir de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo (LCR) o tejidos.

Fuente: *RM N°517-2026/MINSA, que resuelve: Modificar los Anexos 6 y 12 de la Directiva Sanitaria N° 065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias" https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/08/LEPTOSPIROSIS_RM-N°517-2026-MINSA.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/06/Ficha-Clinico-Epidemiologica-Leptospirosis-Humana.pdf

Loxoscelismo

- **Caso probable:** Toda persona que ha sufrido una mordedura de araña del género Loxosceles, cuyo veneno tiene acción proteolítica necrosante, hemolítica y procoagulante, y que se caracteriza por presentar dos formas de manifestación, una cutánea y localizada (Loxoscelismo cutáneo) y otra generalizada (Loxoscelismo cutáneo víscero—hemolítico o sistémico).

- **Caso confirmado:** Caso probable de loxoscelismo en el que se comprueba la mordedura por araña del género Loxosceles spp o que presenta lesiones de tipo proteolíticas necrosantes o hemolíticas.

Fuente: *DS N°065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-PARA-LA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-DE-LAS-ENFERMEDADES-ZOONOTICAS-ACCIDENTES-POR-ANIMALES-PONZONOSOS-Y-EPIZOOTIAS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/fc_Epidemiologica de caso Accidente por animales ponzonosos.pdf

Ofidismo

- **Caso probable:** Toda persona que ha sufrido accidente por mordedura de serpiente venenosa del género Bothrops, Crotallus, Lachesis o Micrurus u otras presentes en el territorio nacional, que al inocular sus toxinas en el organismo provoca una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a síntomas y signos íntimamente relacionados con el género del animal agresor.

- **Caso confirmado:** Caso probable en el que se identifica la especie agresora: *Bothrops, Crotallus, Lachesis, Crotallus, Lachesis o Micrurus* u otra especie venenosa o se instala un cuadro compatible con la toxina de la especie agresora.

Fuente: *DS N°065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-PARA-LA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-DE-LAS-ENFERMEDADES-ZOONOTICAS-ACCIDENTES-POR-ANIMALES-PONZONOSOS-Y-EPIZOOTIAS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/fc_Epidemiologica de caso Accidente por animales ponzonosos.pdf

Peste

- **Caso sospechoso:** Paciente que presenta signos y síntomas clínicos compatibles, y con antecedentes epidemiológicos de:

  - Exposición a humanos o animales infectados, y/o

  - Evidencia de picaduras de pulgas, y/o

  - Residencia o viaje a un área endémica conocida, dentro de los 10 días previos.

- **Caso probable:** Dependerá en qué área se presente el caso sospechoso, si se presenta:

  - **En área potencialmente nueva o re-emergente:** Un caso probable es un paciente que cumple la definición de caso sospechoso y al menos 2 de las siguientes pruebas positivas:

    - Microscopía: muestra de bubón, sangre o esputo que contiene cocobacilos Gram-negativos, bipolares después de tinción Wayson o Giemsa

    - Antígeno F1 detectado en aspirado de bubón, sangre o esputo

    - Una serología anti-F1 única, sin evidencia de infección o inmunización previa con Y. pestis, y

    - Detección de Y. pestis por PCR en aspirado de bubón, sangre o esputo.

  - **En área endémica conocida:** Un caso probable es un paciente que cumple la definición de caso sospechoso y al menos 1 de las pruebas positivas mencionadas en el párrafo anterior.

- **Caso confirmado:** Paciente que cumple la definición de caso sospechoso más:

  - Un aislamiento de una muestra clínica única identificada como Y. pestis (morfología de colonia y 2 de las 4 siguientes pruebas positivas: lisis por bacteriófago de cultivos a 20-25 °C y 37 °C; detección de antígeno; PCR; perfil bioquímico de Y. pestis); o

  - Una elevación en 4 títulos de Anticuerpos anti-F1 en muestras de suero pareadas; o

  - En áreas endémicas, donde no pueda ser realizada otra prueba confirmatoria, una prueba rápida positiva usando una prueba inmunocromatográfica para detectar antígeno F1.

- **Epizootia:** Se notificará obligatoriamente la muerte de roedores y cuyes, que ocurra en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

Fuente: *DS N°065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-PARA-LA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-DE-LAS-ENFERMEDADES-ZOONOTICAS-ACCIDENTES-POR-ANIMALES-PONZONOSOS-Y-EPIZOOTIAS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/Ficha-Clinico-Epidemiologica-de-caso-humano-de-Peste.pdf

Rabia

Rabia humana

- **Caso probable:** Paciente con síndrome neurológico agudo (encefalitis) dominado por formas de hiperactividad seguido de síndromes paralíticos que progresan hacia el coma y muerte, por insuficiencia respiratoria, entre 4 y 10 días después de la aparición del primer síntoma. Con antecedente de mordedura, arañazo o contacto con un animal sospechoso de rabia u otra condición de exposición (trasplantes, riesgo ocupacional, transmisión vertical). El período de incubación puede variar desde 10 días hasta 312 días, generalmente es de 30 a 90 días, con un tiempo promedio de 50 días.

- **Caso confirmado:** Caso probable que es confirmado por laboratorio mediante los resultados positivos de las pruebas de inmunofluorescencia directa (IFD), cultivo celular, inoculación en ratones o RT-PCR. Una prueba positiva en el caso post mortem, de cualquiera de estos exámenes, es concluyente de rabia. En el caso sospechoso de rabia ante mortem, son necesarios al menos dos resultados positivos para confirmar el caso. Los resultados negativos no descartan el caso.

Rabia animal

- **Caso probable de rabia canina:** Perro con cambio de conducta que se esconde en lugares oscuros o muestra intranquilidad, posteriormente se torna agresivo, con tendencia a morder objetos y todo lo que se mueve, hay sialorrea, alteración del ladrido por parálisis de músculos laríngeos y cuerdas vocales, el animal tiende a fugar de su domicilio, luego sobreviene incoordinación muscular, parálisis de las extremidades posteriores y muerte. Con un tiempo de enfermedad no mayor a 10 días. Algunas veces el cuadro clínico solo muestra síntomas de parálisis y muerte.

- **Caso confirmado de rabia canina:** Un resultado positivo de cualquiera de las pruebas confirma el caso: IFD, inoculación en ratones, cultivo celular, RT-PCR y secuenciamiento genético.

- **Caso probable de rabia bovina:** Animal con sintomatología compatible a rabia y con antecedentes de mordedura por murciélago hematófago u otro mamífero, sin haber sido confirmado por el laboratorio. En el bovino los episodios de furia son raros, generalmente presenta inquietud, dilatación de pupilas, lagrimeo, catarro nasal, puede observarse somnolencia y depresión. Al tercer o cuarto día de enfermedad, el animal muestra contracciones tónico-clónicas de la musculatura del cuello, tronco y extremidades, andar tambaleante y muchas veces arrastre de los miembros posteriores. Se produce cese de la rumia, disfagia (dificultad para tragar); se observa eliminación de abundante saliva (apariencia de obstrucción) y deshidratación. La muerte ocurre de 4 a 7 días después del inicio de síntomas.

- **Caso confirmado de rabia bovina:** Un resultado positivo de cualquiera de las pruebas confirma el caso: IFD, inoculación en ratones, cultivo celular, RT-PCR y secuenciamiento genético. El antecedente de mordedura y la procedencia de áreas productivas de rabia (urbana o silvestre) son criterios epidemiológicos importantes para sospechar de rabia. 5. Epizootias: Se notificará la muerte de reservorios de la rabia, mamíferos domésticos y silvestres, susceptibles a la infección del virus rábico.

- **Epizootias:** Se notificará la muerte de reservorios de la rabia, mamíferos domésticos y silvestres, susceptibles a la infección del virus rábico.

Fuente: *DS N°065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias. https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/DIRECTIVA-SANITARIA-PARA-LA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-DE-LAS-ENFERMEDADES-ZOONOTICAS-ACCIDENTES-POR-ANIMALES-PONZONOSOS-Y-EPIZOOTIAS.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/Ficha-Clinico-Epidemiologica-de-caso-de-rabia-humana.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/FICHA-ACTUALIZADA-PARA-ENVIO-DE-MUESTRAS-RABIA.pdf

Vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles

Cáncer

- **Definición de caso:** Persona con confirmación de cáncer por exploración clínica o confirmación anatomo patológica, el tipo de vigilancia que se realiza es activa.

Fuente: *NTS N°199- MINSA/CDC-2023 Norma Técnica de Salud "Vigilancia Epidemiológica de cáncer en general y cáncer en niños y adolescentes – registro hospitalario". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/03/CANCER.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/Ficha-epidemiologica-registro-cancer-general-Anexo3.pdf

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/herramientas/fichas/Ficha-epidemiologica-registro-cancer-ninos-adolescentes-Anexo4.pdf

Diabetes

- **Caso de diabetes:** Persona de cualquier edad, con diagnóstico de diabetes por un profesional medico en base a criterios clínicos (poliuria, polifagia y polidipsia), con test de glicemia en plasma tomada en ayunas de 126 mg/dL o superior, o con un test de glicemia en cualquier hora del día de 200mg/dl o superior. Aquel que fue diagnosticado previamente como diabético y recibe tratamiento hipoglicemiante, aunque tenga un test de glicemia menor de 126 mg/dL, se considera un caso de diabetes.

- **Caso nuevo de diabetes:** Corresponde al paciente diagnosticado por primera vez en el año.

- **Caso prevalente de diabetes:** Corresponde al caso con diagnóstico previo, mediante un test de glicemia o una prueba de tolerancia a la glucosa, sin importar que el paciente haya iniciado o no el tratamiento correspondiente.

- **Caso complicado de diabetes:** Se refiere a la persona con diabetes que al momento de su captación o durante el seguimiento, presenta alguna de las siguientes complicaciones inherentes a la enfermedad:

  - Complicaciones microvasculares:
    - Retinopatía diabética
    - Nefropatía diabética
    - Neuropatía diabética
  - Complicaciones macrovasculares
  - Otras complicaciones:
    - Pie diabético:
    - Episodios de hipoglicemia en los últimos 12 meses
    - Coma diabético
    - Cetoacidosis (CAD)

Fuente: *NTS N°210-MINSA/CDC-2024 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes". https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/normas/normas_2024_19_162346.pdf*

Ficha clínico epidemiológica:

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-de-sobre-vig.-diabetes.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-de-seguimiento-sobre-vig.-diabetes.pdf

Enfermedad Renal Crónica terminal (ERCt)

- **Caso de ERC-t:** Paciente con indicación de inicio de cualquier modalidad de Terapia de Diálisis Crónica que garantice su sobrevivencia.

- **Caso nuevo o caso incidente de ERC-t:** Paciente que es el caso de ERC-t que se registra al momento de iniciar cualquier modalidad de Terapia de Diálisis Crónica.

- **Caso prevalente o continuador de ERC-t:** Paciente que es un caso de ERC-t que ya se encuentra recibiendo cualquier modalidad de terapia Diálisis Crónica al momento de su registro.

Fuente: *NTS N°209-MINSA-CDC-2023 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad renal crónica terminal". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/NORMA-TECNICA-ERCt.pdf*

Ficha clínico epidemiológica:

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Anexo-04-FICHA-DE-CAPTACION-DEL-CASO-INCIDENTE-O-PREVALENTE.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Anexo-05-FICHA-DE-SEGUIMIENTO-DE-CASOS.pdf

Lesiones por accidentes de tránsito

- **Accidente de tránsito:** Colisión en la que participa al menos un vehículo en movimiento por un camino público o privado y que deja al menos una persona herida o muerta.
- **Accidentado de tránsito: Ocupante (ATO):** Lesión no intencional ocasionada directamente por un vehículo automotor en su operación de desplazamiento al ocupante de un vehículo no automotor.
- **Accidentado de tránsito: Peatón (ATP):** Lesión no intencional ocasionada directamente por un vehículo a un peatón.
- **Muerte por accidente de tránsito:** Persona que es lesionada como causa de un accidente de tránsito y muere dentro de los treinta días siguientes.

Fuente: *NTS N°055-MINSA/DGE-V.01 "Norma Técnica de Salud para la vigilancia epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Norma_tecnica-por-accidentes-de-transito.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha_Lesacctra.pdf

Problemas priorizados de salud mental

- **Episodio depresivo moderado:** Se define como la presencia en las últimas dos semanas de al menos seis de los síntomas que se indican a continuación:

  - Ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días;
  - Pérdida de energía;
  - Pérdida de interés en las cosas que antes le gustaban;
  - Pérdida de confianza;
  - Culpabilidad;
  - Conducta suicida;
  - Dificultad para concentrarse;
  - Retardo o agitación psicomotriz;
  - Problemas de sueño; y,
  - Alteración del apetito.

Deben estar presentes obligatoriamente al menos dos de los tres primeros síntomas arriba mencionados. Si el caso corresponde a un niño o adolescente puede considerarse a la irritabilidad como equivalente de ánimo deprimido. El diagnóstico debe haber sido realizado por un especialista en psiquiatría o un profesional médico en base a criterios clínicos.

- **Episodio depresivo grave:** Se define como la presencia en las últimas dos semanas de al menos OCHO de los siguientes síntomas:

  - Ánimo deprimido la mayor parte del día y casi todos los días;
  - Pérdida de energía;
  - Pérdida de interés en las cosas que antes le gustaban;
  - Pérdida de confianza;
  - Culpabilidad;
  - Conducta suicida;
  - Dificultad para concentrarse;

- Retardo o agitación psicomotriz;
- Problemas de sueño; y,
- Alteración del apetito.

Deben estar presentes obligatoriamente los tres primeros síntomas arriba mencionados, además de una clara evidencia de deterioro en el aspecto social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Si el caso corresponde a un niño o adolescente puede considerarse a la irritabilidad como equivalente de ánimo deprimido. El diagnóstico debe haber sido realizado por un especialista en psiquiatría o un profesional médico en base a criterios clínicos.

- **Intento de suicidio:** Conducta potencialmente lesiva autoinfligida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar o no lesiones, independientemente de la letalidad del método.

- **Primer episodio psicótico:** Aparición abrupta, por primera vez en la vida, de un episodio de síntomas psicóticos caracterizado por la presencia de síntomas afectivos y cognitivos de índole positiva (delusiones, alucinaciones y conducta extraña) y también, con frecuencia, de índole negativa (apatía y alogia). El diagnóstico debe haber sido realizado por un médico especialista en psiquiatra en base a criterios clínicos.

  Se debe descartar los casos relacionados con trastornos psicóticos inducidos por sustancias psicótropas (F1X.5), trastorno afectivo episodio maníaco presente con síntomas psicóticos (F31.2), o con episodio depresivo con síntomas psicóticos (F31.5), episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3), trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F33.3).

Fuente: *DS Nº071-MINSA/CDCV.01 "Directiva Sanitaria para la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en establecimientos de salud centinela y mediante encuesta poblacional". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/RM-496-2016-MINSA-Directiva-Sanitaria-071-MINSA-CDC-Vigilancia-Salud-Mental.pdf*

Ficha clínico epidemiológica:

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Fichas_de_vigilancia_PRIMER_EPISODIO_PSICOTICO.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Fichas-_de_vigilancia_INTENTO_SUICIDA.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Fichas_de_vigilancia_DEPRESIVO_MODERADO_SEVERO.pdf

Violencia familiar

- **Caso probable:** Sera considerado como caso probable, a toda persona de sexo femenino o masculino, que presente lesiones físicas, sexuales o psicol6gicas que sean compatibles con el síndrome de Maltrato.

- **Caso confirmado:** Sera considerado caso confirmado cuando una persona presente los signos y síntomas descritos en el caso probable, además de haber sido referida y atendida en una unidad policial.

- **Caso de defunción por violencia familiar:** Es la muerte de una persona por causa directa o asociada a una situaci6n de violencia familiar.

Fuente: *Directiva N°001-OGE-ENT 2000 "Directiva de la Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Familiar". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/directiva_violencia_familiar.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://app7.dge.gob.pe/notiWeb/assets/images/Ficha_vfamiliar.pdf

Vigilancia epidemiológica materno perinatal

Morbilidad Materna Extrema (MME)

- **Caso de morbilidad materna extrema:** Mujer que casi muere, pero que sobrevive a una complicación grave presentada durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, y que presenta uno o más criterios de inclusión.

Fuente: *NTS N° 174-MINSA/2021/CDC "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema". https://www.dge.gob.pe/portal/docs/normas/MORBILIDAD MATERNA EXTREMA_Norma tecnica de salud para la vigilancia epidemiologica.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/01/Ficha-MME.pdf

Muerte Fetal y Neonatal (MFN)

- **Muerte fetal:** Es la defunción de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, a partir de las 22 semanas de gestación o peso igual mayor a 500 gramos. La muerte fetal está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

- **Muerte neonatal:** Es la defunción de un recién nacido vivo, que ocurre en el intervalo comprendido desde su nacimiento hasta cumplidos los 28 días de vida.

Fuente: *NTS N°078-MINSA/DGE-V.01 "Norma Técnica de Salud que establece el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal". https://www.dge.gob.pe/normas/rm/2009/RM279-2009_Z.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2026/02/MUERTE-FETAL-Y-NEONATAL_Ficha-de-notificacion-de-muerte-neonatal-y-perinatal.pdf

Muerte Materna (MM)

- **Muerte materna directa:** Muerte obstétrica que resulta de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originados en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

- **Muerte materna indirecta:** Muerte obstétrica que resulta o deriva de una enfermedad previamente existente o enfermedad que apareció durante el embarazo y que no fue debida a causas obstétricas directas, pero agravada por los efectos o cambios fisiológicos propios del embarazo.

- **Muerte materna incidental:** Muerte que no resulta de complicaciones obstétricas ni de una enfermedad preexistente o intercurrente agravada por efecto de la misma, y que ocurre por una causa externa a la salud de la madre, es decir, por causas accidentales o violentas.

- **Muerte materna tardía:** Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la culminación del embarazo. No se consideran para el cálculo de razón o tasa de muerte materna.

- **Muerte por secuelas de causas obstétricas:** Muerte materna que ocurre un año o más después de la culminación del embarazo, debido a causas obstétricas directas o indirectas.

Fuente: *NTS N°227-MINSA/CDC-2025 «Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna en el Perú». https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/MUERTE-MATERNA_NTS-N%C2%B0227-MINSACDC-2025.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/MUERTE-MATERNA_Ficha-de-notificacion-inmediata-de-muerte-materna.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/MUERTE-MATERNA_Ficha-de-Investigacion-epidemiologica-de-muerte-materna.pdf

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2025/06/MUERTE-MATERNA_Ficha-de-autopsia-verbal-de-muerte-materna.pdf

Vigilancia epidemiológica de riesgos ambientales

Riesgo por exposición e intoxicación por metales pesados y metaloides

- **Caso sospechoso (expuesto):** Es toda persona con antecedente de exposición a fuente confirmada (natural y/o antrópica), que tenga metales pesados y metaloides en el aire o agua o suelo o alimentos que sobrepasa los valores de referencia sin manifestaciones clínicas de intoxicación aguda o crónica por metales pesados y metaloides.

- **Caso probable:** Es todo caso sospechoso (expuesto) y que presenta manifestaciones clínicas de intoxicación aguda o crónica por metales pesados y metaloides diagnosticado por un médico que no puedan ser explicados por otra patología.

- **Caso Confirmado (Intoxicado):** Es el caso probable con confirmación de laboratorio.

- **Caso descartado:** Es aquel caso que luego de la investigación epidemiológica y evaluación médica, no cumple con los criterios de caso confirmado o probable.

Fuente: *NTS N°111-2014-MINSA/DGE-V.01 "Norma Técnica de Salud que Establece la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de Factores de Riesgo por Exposición e Intoxicación por Metales Pesados y Metaloides". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/NTS-Nro-111-2014_Metales-pesados.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Ficha_Metalespesados.pdf

Riesgo de exposición e intoxicación por plaguicidas

- **Caso sospechoso (expuesto):** Es la persona o población en contacto directo e indirecto a plaguicidas, sin manifestaciones clínicas.

- **Caso probable de intoxicación:** Es la persona expuesta o población expuesta a plaguicidas, que dentro de las primeras 24 horas presenta manifestaciones clínicas compatible con una intoxicación sistémica (náuseas, bradicardia, miosis, entre otros síntomas y signos) o localizada (dermatitis entre otros síntomas y signos).

- **Caso confirmado de intoxicación:** Es aquel caso que se establece por presentar uno de los siguientes criterios:

  - **Caso confirmado por criterio clínico – epidemiológico:** Todo caso que presenta manifestaciones clínicas de intoxicación por exposición a plaguicidas y el antecedente de haber estado en contacto directo o indirecto, en la cual se ha investigado la vía de exposición, dosis y el tiempo transcurrido. En caso de fallecimiento la confirmación se realizará con procedimientos médicos legales.

  - **Caso confirmado por criterio de laboratorio:** Todo caso probable de intoxicación con evidencia de una prueba de laboratorio confirmatoria de intoxicación por plaguicidas en muestras biológicas (sangre, orina y otros fluidos), según corresponda.

- **Caso descartado:** Todo caso probable que luego de la investigación epidemiológica y de laboratorio no corresponde a una intoxicación por plaguicidas.

Fuente: *NTS N°109-MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud que Establece la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública del Riesgo por Exposición e Intoxicación por Plaguicidas". https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/NTS-Nro-109-2015_Plaguicidas.pdf*

Ficha clínico epidemiológica

https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2024/05/Ficha_Plaguicidas.pdf

Bibliografía

1. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria de Notificación de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. DS N°046-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2013.

2. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Perú. NTS N°115-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2015.

3. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema. NTS N°174-MINSA/2021/CDC. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2021.

4. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud que establece el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal. NTS N°078-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2011.

5. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna en el Perú. NTS N°227-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

6. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Sífilis Materna y Sífilis Congénita. DS N°062-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2015.

7. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis. DS N°079-MINSA/2017/CDC. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2017.

8. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI). DS N°054-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2014.

9. Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Perú). Alerta Epidemiológica N° 024-2020: Riesgo de transmisión de Difteria ante la confirmación de un caso en el Perú. Lima: MINSA/CDC; 2020

10. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis Viral B en el Perú. NTS N°146-MINSA/2018/DGIESP. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2018.

11. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda. DS N°059-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2015.

12. Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Perú). Alerta Epidemiológica N° 013-2019: Incremento de brotes de parotiditis en poblaciones de entorno cerrado a nivel nacional. Lima: MINSA/CDC; 2019.

13. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Sarampión, Rubéola y otras Enfermedades Febriles Eruptivas. DS N°049-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2013.

14. Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología (Perú). Compendio de Definiciones de Caso de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica. Lima: MINSA; 2014

15. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Tos Ferina. NTS N°206-MINSA/CDC-2023. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2023.

16. Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Perú). Alerta Epidemiológica N° 011-2017: Ante incremento estacional de casos de varicela en el Perú. Lima: MINSA/CDC; 2017

17. Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (Perú). Alerta Epidemiológica N° 009-2024: Actualización de la Alerta por el riesgo de Introducción del Clado Ib de Mpox en el Perú. Lima: MINSA/CDC; 2024.

18. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Viruela del Mono (Viruela Símica) en el Perú. NTS N°195-MINSA/CDC-2022. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2022.

19. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche, Mayaro y otras Arbovirosis en el Perú. NTS N°230-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

20. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad de Carrión. NTS N°231-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

21. Ministerio de Salud del Perú. Oficina General de Epidemiología. Protocolos de vigilancia epidemiológica. Parte I. Serie normas de vigilancia epidemiológica en salud pública. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2006.

22. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Leishmaniasis en el Perú. NTS N°225-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

23. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en el contexto de la Eliminación de la Malaria en el Perú. NTS N°228-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

24. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias. DS N°065-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2016.

25. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia, Prevención y Control de la Fasciolosis Humana en el Perú. NTS N°148-MINSA/DIGIESP V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2018.

26. Ministerio de Salud (Perú). Resolución Ministerial N° 517-2026/MINSA: Modifica los Anexos 6 y 12 de la Directiva Sanitaria N° 065-MINSA/DGE-V.01 "Directiva Sanitaria para la vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas, Accidentes por Animales Ponzoñosos y Epizootias". Lima: MINSA; 2026

27. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el Perú. NTS N°190-MINSA/CDC-2022. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2022.

28. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Diarreas por Rotavirus en Niños/as menores de 5 años en Hospitales Centinela. DS N°073-MINSA/CDC V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2017.

29. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por Campylobacter spp. en Hospitales Centinela. DS N°146-MINSA/CDC-2022. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2022.

30. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). DS N°061-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2015.

31. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Neumonías y Meningitis Bacterianas en Niños y Niñas menores de 5 años en Hospitales Centinela. DS N°074-MINSA/CDC V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2017.

32. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19), Fase Endémica en el Perú. NTS N°224-MINSA/CDC-2025. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2025.

33. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, otros Virus Respiratorios (OVR) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en el Perú. DS N°045-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2013.

34. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio del Síndrome de Guillain-Barré en el Perú. NTS N°175-MINSA/2021/CDC. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2021.

35. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud Vigilancia Epidemiológica de Cáncer en General y Cáncer en Niños y Adolescentes – Registro Hospitalario. NTS N°199-MINSA/CDC-2023. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2023.

36. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Diabetes. NTS N°210-MINSA/CDC-2024. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2024.

37. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica Terminal. NTS N°209-MINSA/CDC-2023. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2023.

38. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Accidentes de Tránsito. NTS N°055-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2011.

39. Ministerio de Salud del Perú. Directiva Sanitaria para la Vigilancia de Problemas de la Salud Mental Priorizados en Establecimientos de Salud Centinela y mediante Encuesta Poblacional. DS N°071-MINSA/CDC V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2017.

40. Ministerio de Salud del Perú. Oficina General de Epidemiología. Directiva de la Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Familiar. Directiva N°001-OGE-ENT. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2000.

41. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud que Establece la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de Factores de Riesgo por Exposición e Intoxicación por Metales Pesados y Metaloides. NTS N°111-2014-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2014.

42. Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica de Salud que Establece la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública del Riesgo por Exposición e Intoxicación por Plaguicidas. NTS N°109-MINSA/DGE V.01. Lima: Ministerio de Salud del Perú; 2014.

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Salud Pública | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

RED NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA · RENACE ·

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Ministerio de Salud
Calle Daniel Olaechea N° 199, Jesús María,
Lima Perú
www.dge.gob.pe